

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PT ASURANSI BRI LIFE
DENGAN
PT. DISA PRIMA MEDIKA
TENTANG
PELAYANAN KESEHATAN SECARA BERLANGGANAN**

Nomor: B. 892/PMO/PHC/II/2025

Nomor: 046.4/DPM/E-PKS/DIR/II/2025

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat pada hari ini **Jumat**, tanggal **Dua Puluh Delapan** Bulan **Februari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** bertempat di **Jakarta** oleh dan antara :

1. **Anna Novy Handayani** jabatan **Kepala Project Healthcare**, Berdasarkan Akta Pendirian Nomor: 116 tanggal 28 Oktober 1987, Akta Nyonya Poerbaningsih Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta, disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: C2-6645.HT.01.01-TH.88 tanggal 2 Agustus 1988, dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 71 Tanggal 04 September 1990, Anggaran Dasar telah mengalami beberapa kali perubahan, Akta Nomor: 8 tanggal 2 Maret 2021, yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, SH., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan, disahkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0013073.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 2 Maret 2021, perubahan terakhir perubahan terakhir Akta Nomor: 11 tanggal 11 Maret 2023, yang dibuat oleh notaris Jose Dima Satria, SH., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan, disahkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03.0033868 tanggal 2 Maret 2023 **perubahan terakhir Akta No. 25 tanggal 8 Juni 2023 yang dibuat oleh Notaris Jose Dima Satria, SH., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan, disahkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0033982.AH.01.02 Tahun 2023, dan berdasarkan Surat Kuasa No ...** oleh karena itu sah menurut hukum bertindak untuk dan atas, oleh karena itu sah menurut hukum bertindak untuk dan atas nama PT Asuransi BRI Life, berkedudukan di Gedung Graha Irama Lantai 5, 7, dan 15, Jalan H.R Rasuna Said Blok X-1 Kav. 1&2 Jakarta Selatan Kode Pos 12950, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

Hlm. 1 dari 37

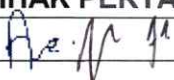
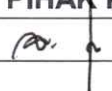
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

2. **dr. Sefrina Trisadi, Sp. DVE** sebagai Direktur **PT. DISA PRIMA MEDIKA** didirikan berdasarkan Akta nomor 26, tanggal 28 (Dua Puluh Delapan) 11 (November) 2009 (Dua Ribu Sembilan), dibuat dihadapan Endang Merduwati, S.H , Sarjana Hukum, Notaris di Kota Malang, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya Nomor AHU-63604.AH.01.01.Tahun 2009 tertanggal 31 (Tiga Puluh Satu) 12 (Desember) 2009 (Dua Ribu Sembilan) serta yang telah diumumkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS) Perseroan Terbatas PT. Disa Prima Medika No. 10 tanggal 16 (Enam Belas) 10 (Oktober) 2018 (Dua Ribu Delapan Belas) yang dibuat di hadapan Yudo Sigit Riswanto, SH., Sarjana Hukum, Notaris di Kota Malang, selaku Badan Usaha pengelola Rumah Sakit :
- Rumah Sakit Prima Husada Malang** dengan Izin Operasional Rumah Sakit No.81201150815810001 tertanggal 17 Mei 2022 diwakili oleh dr. Nur mazidah sebagai Direktur Rumah Sakit Prima Husada yang beralamat di Jl. Banjararum Selatan No. 3 – 7 Kecamatan Singosari Kabupaten Malang.
 - Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo** dengan Izin Operasional Rumah Sakit No 81201150810004 tertanggal 20 September 2023 diwakili oleh Ns. Heni Indra Wulansari, S. Kep., M. Kep sebagai PLT Direktur Rumah Sakit Prima Husada yang beralamat di Jl. Raya Surabaya –Malang Km 54, Desa Lemahbang Kecamatan Sukorejo – Pasuruan selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri sendiri disebut **PIHAK**, menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut :

- Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah perusahaan asuransi jiwa dalam Perjanjian Kerja Sama ini menjamin biaya pelayanan kesehatan para Peserta **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan Polis Asuransi.
- Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Rumah Sakit Swasta yang merupakan Rumah Sakit Grup dan oleh karena itu menyatakan berhak dan berwenang mewakili seluruh cabang/anak perusahaan di bawah kendali **PIHAK KEDUA**.
- Bahwa oleh karena itu **PIHAK PERTAMA** bekerja sama dengan **PIHAK KEDUA** untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada Peserta **PIHAK PERTAMA**.

Hlm. 2 dari 37

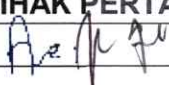
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas **PARA PIHAK** sepakat mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pelayanan Kesehatan Secara Berlangganan untuk selanjutnya disebut "**Perjanjian Kerja Sama**" dengan ketentuan yang diatur berdasarkan ketentuan-ketentuan dibawah ini:

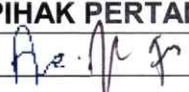
PASAL 1 PENGERTIAN

1. **Peserta** adalah pihak yang menjadi tanggungan **PIHAK PERTAMA** yang memenuhi syarat pertanggungan sebagaimana diatur dalam Polis Asuransi yang juga merupakan **Pasien**.
2. **Pasien** adalah setiap orang yang memperoleh Pelayanan Kesehatan dari **PIHAK KEDUA**.
3. **Pelayanan Kesehatan** adalah layanan kesehatan yang diberikan oleh Rumah Sakit kepada Peserta/ Tertanggung sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan kesehatan dan rumah sakit, termasuk tetapi tidak terbatas pada Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang terdiri antara lain Layanan Kesehatan Rawat Inap dan/ atau Layanan Kesehatan Rawat Jalan dan/ atau Layanan Gawat Darurat dan Observasi 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam.
4. **Rawat Jalan** adalah semua jasa Pelayanan Kesehatan yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA** kepada Pasien di rumah sakit **PIHAK KEDUA** dalam upaya perawatan/ atau pengobatan atau pemulihan kesehatan dimana Pasien tidak perlu menginap di Rumah Sakit **PIHAK KEDUA**.
5. **Rawat Inap** adalah semua jasa Pelayanan Kesehatan yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA** kepada Pasien di rumah sakit **PIHAK KEDUA** dalam upaya perawatan dan/ atau pengobatan atau pemulihan kesehatan dimana Pasien perlu menginap di rumah sakit **PIHAK KEDUA** atau paling sedikit observasi selama lebih dari 8 (delapan) jam. Dalam hal Pembedahan yang tidak memerlukan Rawat Inap, jangka waktu 8 (delapan) jam tersebut tidak berlaku.
6. **One Day Care** adalah layanan kesehatan berupa tindakan medis tertentu yang dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) hari kalender tanpa Rawat Inap.

Hlm. 3 dari 37

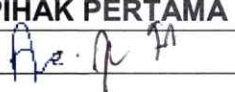
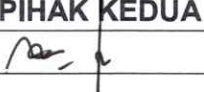
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

7. **Gawat Darurat** adalah tindakan medis yang harus diberikan sebagai pertolongan pertama untuk mengatasi keadaan darurat pada Pasien yang dilakukan di UGD (unit Gawat Darurat) pada rumah sakit **PIHAK KEDUA**.
8. **Surat Jaminan Pelayanan** adalah surat yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari **PIHAK PERTAMA** yang mencantumkan data-data Pasien dan batasan biaya (*Plafond*) perawatannya, untuk dipergunakan sebagai pengantar bagi Pasien guna memperoleh Pelayanan Kesehatan dari **PIHAK KEDUA**, serta merupakan jaminan pembayaran dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** atas Pelayanan Kesehatan yang telah diberikan oleh **PIHAK KEDUA**.
9. **Fasilitas Pelayanan Kesehatan** adalah sarana dan pra-sarana yang dipergunakan untuk Rawat Inap, Rawat Jalan dan Gawat Darurat yang meliputi pemeriksaan kesehatan, pengobatan, penggunaan obat-obat farmasi, penggunaan alat-alat kesehatan, pemeriksaan penunjang medis, penggunaan alat-alat penunjang medis atau tindakan medis yang dianggap perlu oleh dokter umum atau dokter spesialis.
10. **Rumah Sakit Lain** adalah rumah sakit yang merupakan fasilitas rujukan dari dokter yang merawat Pasien.
11. **Aplikasi BRILIFE-Care** adalah sistem informasi milik **PIHAK PERTAMA** yang diakses dan digunakan oleh **PIHAK KEDUA** untuk pelayanan kesehatan di **PIHAK KEDUA** mulai dari tahap awal pelayanan hingga tahap penagihan Klaim;
12. **Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan** yang selanjutnya disingkat **BPJS Kesehatan** adalah Badan hukum publik yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN);
13. **Bahan dan Alat Kesehatan Habis Pakai (BAHP)** adalah bahan dan alat kesehatan yang digunakan oleh **PIHAK KEDUA** dalam rangka melakukan diagnosa, pengobatan, dan perawatan yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA**;
14. **Berkas Elektronik** adalah berkas/dokumen pengajuan Klaim berupa *hardcopy*/berkas fisik yang dialihmediakan kedalam bentuk elektronik (*softcopy*) yang diajukan oleh **PIHAK KEDUA** melalui Aplikasi BRILIFE-Care;

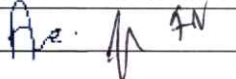
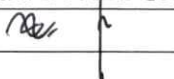
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

15. **Formularium Rumah Sakit** adalah obat yang pengadaannya dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** dan diresepkan oleh dokter **PIHAK KEDUA** kepada Peserta disesuaikan dengan kebutuhan peserta **PIHAK PERTAMA** dengan batasan manfaat secara wajar dan atau tidak berlebihan (terkendali).
16. **Hari Kalender** adalah setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender masehi ;
17. **Hari Kerja** adalah hari selain hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional
18. **Hari Rawat** adalah perhitungan jumlah Hari Rawat Inap Peserta di **PIHAK KEDUA** yaitu: dimulai dari tanggal masuk sampai dengan tanggal keluar dengan ketentuan apabila tanggal keluar sama dengan tanggal masuk, maka dihitung sebagai 1 (satu) Hari Rawat inap atau perhitungan rawat inap lain yang disepakati antara **PARA PIHAK** secara kasus per kasus;
19. **Indonesian-Case Based Group (INA-CBG)** adalah tarif klaim yang ditetapkan oleh BPJS Kesehatan kepada fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan atas paket pelayanan kesehatan yang didasarkan kepada pengelompokan diagnosis penyakit dan prosedur;
20. **Aplikasi INA CBG** adalah System yang digunakan oleh BPJS Kesehatan ke seluruh Rekanan Provider BPJS Kesehatan
21. **Jenis Pelayanan (Jenpel)** adalah daftar pelayanan kesehatan dan tarif kesepakatan yang disepakati **PARA PIHAK** yang diatur dalam Lampiran III Perjanjian Kerja Sama ini;
22. **Kartu Peserta** adalah kartu kepesertaan yang diterbitkan oleh **PIHAK PERTAMA** sebagai alat bukti yang sah atas kepesertaan seseorang berdasarkan polis asuransi kesehatan yang dikeluarkan oleh **PIHAK PERTAMA** untuk memperoleh Layanan Kesehatan dengan sarana dan fasilitas **PIHAK KEDUA**, Kartu Peserta dengan logo **BRI LIFE** untuk **Layanan Kesehatan Rawat Inap dan Layanan Kesehatan Rawat Jalan** (Contoh Kartu pada lampiran II) yang akan diproses melalui BRILIFE-Care.
23. **E-Card** adalah Kartu Peserta berbentuk digital yang dapat diakses dalam aplikasi BRILIFE-Care.
24. **Formulir Pengajuan Klaim (FPK)** adalah formulir standar **PIHAK PERTAMA**, yang wajib dilengkapi oleh **PIHAK KEDUA** dan disertakan pada saat pengajuan Klaim kepada **PIHAK PERTAMA**;

Hlm. 5 dari 37

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

25. **Kelas Perawatan** adalah fasilitas Rawat Inap termasuk pelayanan obat yang menjadi hak Peserta sesuai dengan plan pada Kartu BRILIFE yang dimiliki Peserta
26. **Coordination of Benefit BPJS Kesehatan** selanjutnya disingkat **COB BPJS Kesehatan** adalah suatu proses dimana dua atau lebih penanggung (payer) yang menanggung orang yang sama untuk benefit kesehatan yang sama, membatasi total benefit dalam jumlah tertentu yang tidak melebihi jumlah pelayanan kesehatan yang dibiayakan, sesuai Peraturan Menteri Kesehatan No. 3 tahun 2023 serta peraturan terkait, peraturan baru atau peraturan tambahan lainnya yang mendukung jalannya pelayanan COB BPJS Kesehatan ini.
27. **Provider Irisan** adalah Provider mitra dari **PIHAK PERTAMA** yang terdaftar sebagai sarana pelayanan kesehatan BPJS Kesehatan;
28. **Rekam Medis** adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan Provider kepada Peserta;
29. **Rawat Inap Tingkat Lanjutan** selanjutnya disingkat **RI** adalah pelayanan yang bersifat spesialis/ subspesialis untuk keperluan observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, Rehabilitasi Medis dan atau pelayanan medis lainnya, pada Provider Tingkat Lanjutan yang mana Peserta dirawat inap di ruang perawatan/perawatan khusus paling sedikit 1 (satu) hari;
30. **Rehabilitasi Medis** adalah pelayanan yang diberikan oleh instalasi Rehabilitasi Medis dalam bentuk fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, dan bimbingan sosial medik;
31. **Rujukan** adalah sistem aturan pelimpahan tugas dan tanggung jawab pelayanan kesehatan secara timbal balik antar Provider Tingkat Pertama dengan Provider Tingkat Lanjutan;
32. **Telemedicine** adalah sebagaimana dijelaskan pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 20 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan *Telemedicine* Antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan atau perubahannya dari waktu ke waktu.

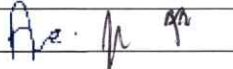
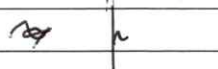
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

33. **Tindakan Medis** adalah tindakan yang bersifat operatif dan non operatif yang dilaksanakan baik untuk tujuan diagnostik maupun pengobatan sesuai dengan indikasi medis serta tidak berlebihan dan atau terkendali
34. **Verifikasi Klaim** adalah upaya pemeriksaan kelengkapan/kebenaran berkas kelayakan Klaim yang diajukan kepada **PIHAK PERTAMA** oleh **PIHAK KEDUA**/Peserta, sesuai dengan ketentuan
35. **Ekses Klaim** adalah selisih biaya yang timbul antara biaya perawatan di **PIHAK KEDUA** dengan manfaat asuransi yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA**.
36. **Surat Elegibilitas Peserta** yang selanjutnya disingkat **SEP**, surat yang dikeluarkan oleh Fasilitas Kesehatan tingkat 1 dari BPJS Kesehatan untuk di daftarkan ke Fasilitas Kesehatan Lanjutan BPJS Kesehatan.
37. **Surat Pendaftaran/Otorisasi (Letter of Authorization-LoA)** adalah slip pengesahan yang diterbitkan oleh **PIHAK PERTAMA** mengenai batas manfaat asuransi kesehatan atau kebijakan fasilitas kesehatan perusahaan sesuai dengan hak Peserta dan digunakan sebagai informasi bagi **PIHAK KEDUA** dan Peserta melakukan rawat inap dan rawat jalan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 6 Perjanjian Kerja Sama perihal Struk Pengobatan.m
38. **Surat Pengesahan “(Letter of Confirmation-LoC)”** adalah slip pengesahan yang diterbitkan oleh **PIHAK PERTAMA** mengenai batas manfaat asuransi kesehatan atau kebijakan fasilitas kesehatan perusahaan Peserta sebagai informasi bagi **PIHAK KEDUA** dan Peserta yang diterbitkan setelah Peserta melakukan pemeriksaan rawat jalan;
39. **Berkas Softcopy** adalah salinan dokumen/informasi yang berbentuk digital atau elektronik, seperti termasuk namun tidak terbatas pada dokumen word, pdf, dan lain sebagainya.
40. **Berkas Hardcopy** adalah salinan dokumen/informasi yang dicetak langsung berbentuk fisik, seperti termasuk namun tidak terbatas pada memo, nota, katalog, dan sebagainya.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Hlm. 7 dari 37

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

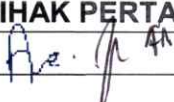
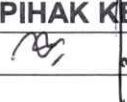
1. Pelayanan kesehatan yang diberikan **PIHAK KEDUA** kepada Peserta meliputi pelayanan Rawat Inap dan Rawat Jalan serta pelayanan kesehatan lain seperti pengobatan dan/atau penggunaan peralatan kedokteran, kamar bedah, pemeriksaan laboratorium/ radiologi dan asuhan keperawatan, serta tindakan lain yang lazim dalam pelayanan kesehatan yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA**.
2. Ruang lingkup dan prosedur pelayanan kesehatan yang dimaksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah
 - a. Prosedur Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan dan Rawat Inap;
 - b. Prosedur Pelayanan Kesehatan COB BPJS KESEHATAN;
 - c. Prosedur Pelayanan Kesehatan Telemedicine.

PASAL 3

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

1. Tanpa mengesampingkan hak **PIHAK PERTAMA** sebagaimana diatur dalam Pasal-Pasal lain dalam Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PIHAK PERTAMA** berhak untuk:
 - a. Melihat dan mengakses kartu status dan/atau Rekam Medis dan berkas fisik atas pelayanan Peserta yang dikirimkan kepada **PIHAK PERTAMA** melalui pertukaran data elektronik, *softcopy* atau *hardcopy* dalam hal diperlukan oleh **PIHAK PERTAMA**;
 - b. Melakukan peninjauan atas pelayanan kesehatan yang diberikan **PIHAK KEDUA** kepada Peserta dengan cara, termasuk tetapi tidak terbatas pada, mendapatkan data dan informasi tentang fasilitas **PIHAK KEDUA** dan kunjungan Peserta;
 - c. Melakukan audit atau pemeriksaan terhadap **PIHAK KEDUA** apabila terdapat dugaan penyalahgunaan pelayanan kesehatan dan/atau surat pesanan obat/resep kepada Peserta atau non Peserta;
 - d. Memberikan teguran atau peringatan lisan dan/atau tertulis kepada **PIHAK KEDUA** dalam hal **PIHAK PERTAMA** menemukan terjadinya penyimpangan terhadap pelaksanaan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini oleh **PIHAK KEDUA**;
 - e. Memberikan sanksi kepada **PIHAK KEDUA** dalam hal **PIHAK PERTAMA** menemukan terjadinya penyimpangan terhadap pelaksanaan kewajiban **PIHAK KEDUA**;
 - f. Menerima data dan informasi termasuk namun tidak terbatas pada dokumen uji tuntas **PIHAK KEDUA**/Provider *due diligence* dalam rangka pemenuhan peraturan

Hlm. 8 dari 37

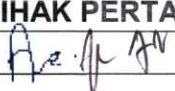
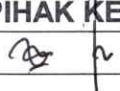
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- perundangan, Berkas Elektronik dan/atau dokumen, data lainnya yang dibutuhkan **PIHAK PERTAMA** secara benar, sah dan akurat baik melalui pertukaran data elektronik dan/atau dokumen fisik, apabila diperlukan oleh **PIHAK PERTAMA**;
- g. Menerima tagihan elektronik yang dihasilkan dari Aplikasi **BRILIFE-Care** yang ditetapkan **PIHAK PERTAMA** atas biaya pelayanan kesehatan dan obat bagi Peserta secara teratur setiap bulan kepada **PIHAK PERTAMA**;
 - h. Mendapatkan kepastian bahwa pelayanan kesehatan yang diberikan **PIHAK KEDUA** kepada Peserta sesuai indikasi medis dan standar serta prosedur pelayanan kesehatan yang berlaku atau dengan mengutamakan prinsip kendali mutu dan kendali biaya serta pertanggungjawaban **PIHAK KEDUA** atas pelayanan kesehatan yang diberikan kepada Peserta dalam melaksanakan kewajibannya dalam Perjanjian Kerja Sama ini;
 - i. Menerima dokumen-dokumen termasuk namun tidak terbatas pada tagihan Klaim yang ditandatangani oleh perwakilan sah **PIHAK KEDUA** yang memiliki kapasitas, kewenangan serta cakap untuk melakukan hal tersebut;
 - j. Mendapatkan akses untuk menggunakan seluruh dokumen terkait dengan Klaim untuk kepentingan audit internal/eksternal.
2. Tanpa mengesampingkan kewajiban **PIHAK PERTAMA** sebagaimana diatur dalam Pasal-Pasal lain dari Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk:
 - a. Membayar Klaim sepanjang memenuhi ketentuan dan prosedur yang telah disepakati **PARA PIHAK** sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini;
 - b. Memberikan akses Aplikasi **BRILIFE-Care** kepada **PIHAK KEDUA** untuk kepentingan pelayanan kesehatan Peserta

PASAL 4

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1. Tanpa mengesampingkan hak **PIHAK KEDUA** sebagaimana diatur dalam Pasal-Pasal lain dari Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PIHAK KEDUA** berhak untuk:
 - a. Menerima informasi tentang ruang lingkup dan prosedur pelayanan kesehatan yang disediakan bagi Peserta;

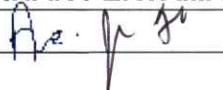
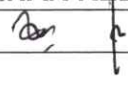
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- b. Memperoleh pembayaran biaya pelayanan kesehatan dari **PIHAK PERTAMA** atas pelayanan kesehatan yang telah diberikan oleh **PIHAK KEDUA**, sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang telah disepakati **PARA PIHAK** sebagaimana diatur dalam pasal 7 Perjanjian Kerja Sama ini;
2. Tanpa mengesampingkan kewajiban **PIHAK KEDUA** sebagaimana diatur dalam Pasal-Pasal lain dari Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
 - a. Memberikan **PIHAK PERTAMA** hak untuk mengakses dan/atau melihat kartu status dan/atau Rekam Medis dan bukti pelayanan Peserta baik secara pertukaran data elektronik, *softcopy* atau *hardcopy* apabila diperlukan;
 - b. Melampirkan seluruh dokumen klaim yang diperlukan oleh **PIHAK PERTAMA** sebagaimana yang diatur dalam pasal 7 ayat (9), ayat (10) dan ayat (11) Perjanjian Kerja Sama ini secara lengkap, benar dan sah
 - c. Memberikan Manfaat Pelayanan dengan baik dan benar sesuai yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini;
 - d. Melayani Peserta dengan baik sesuai indikasi medis dan standar serta prosedur pelayanan kesehatan yang berlaku atau dengan mengutamakan prinsip kendali mutu dan kendali biaya, dan oleh karenanya bertanggungjawab penuh dalam kapasitasnya selaku pemberi pelayanan kesehatan kepada Peserta dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini;
 - e. Dalam hal **PIHAK KEDUA** juga sebagai Provider Irisan maka **PIHAK KEDUA** wajib memberikan pelayanan sesuai mekanisme Manfaat CoB BPJS Kesehatan yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, menerbitkan SEP dan juga mengajukan tagihan elektronik dengan mekanisme *split billing* melalui INA-CBG dan selisih yang terjadi dibayar ditempat oleh peserta setelah hasil perhitungan selisih pengurangan INACBG.
 - e. Mengakses dan menggunakan aplikasi **PIHAK PERTAMA** untuk kepentingan pelayanan kesehatan Peserta BRILIFE yang terdiri dari Aplikasi BRILIFE-Care.

PASAL 5

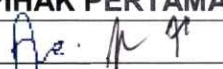
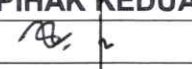
BIAYA PERAWATAN DAN PENGOBATAN YANG TIDAK DIJAMIN OLEH PIHAK PERTAMA

Hlm. 10 dari 37

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

1. Pengeluaran terhadap biaya-biaya yang tidak berhubungan dengan kegiatan yang bersifat Medis yang semata mata untuk kenyamanan Peserta (misalnya: pemakaian fasilitas telepon, *facsimile*, *laundry* dsb).
2. Biaya Operasi dan Perawatan untuk Tujuan Kecantikan, Hemodialisi (cuci darah), Alat Pacu Jantung, Alat Protesa, Alat Bantu Dengar dan Transplantasi Organ Tubuh termasuk Sumsum Tulang Belakang.
3. Penyalahgunaan Kartu Peserta dan adanya penyimpangan fasilitas yang diberikan.
4. Biaya pengobatan terhadap Kondisi Bawaan Sejak Lahir yang telah diketahui dan telah ada sebelum masa Pertanggungan.
5. Biaya Pengobatan Psikosis, Neurosis, Penyakit Jiwa dan Penyakit Mental lainnya (termasuk setiap Manifestasi dari gangguan Kejiwaan atau Psikosomatik).
6. Biaya Perawatan Khusus (Rest Cures) dan Perawatan yang semata-mata hanya untuk membantu seseorang dalam menjalankan kegiatan sehari-harinya (Custodial Care) Contoh: Kursi Roda, Kruk atau Perawatan Suster Pribadi di rumah.
7. Biaya Perawatan penyakit atau cedera yang timbul dari atau berhubungan dengan penyalahgunaan Alkohol, Narkotika atau obat-obatan lainnya (kecuali akibat dari obat-obatan yang berdasarkan resep dokter dan bertujuan medis), Bunuh Diri, Percobaan Bunuh Diri, Cedera yang disengaja, Keterbukaan yang disengaja terhadap Bahaya Besar.
8. Tindakan tindakan atau perlengkapan yang berhubungan dengan aborsi (kecuali atas pertimbangan Medis), PAP's Smear atau Test yang tidak berhubungan dengan pengobatan (Tes Alergi, Penurunan Berat Badan), Sterilisasi dan Mendapatkan Kesuburan, Mendapatkan Bayi Tabung, termasuk penyakit-penyakit yang timbul akibat keadaan tersebut.
9. Pengobatan penyakit atau cedera yang timbul dari atau berhubungan dengan semua jenis olah raga beresiko tinggi.
10. Segala jenis Vitamin, Food Supplement yang dipergunakan bukan untuk suatu penyembuhan, Imunisasi (Imunisasi bukan dasar atau yang bukan program pemerintah seperti DPT Polio Tidak Panas, HIB, MMR), Pemeriksaan Fisik dan Laboratorium yang bertujuan untuk pengecekan kesehatan saja.

Hlm. 11 dari 37

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

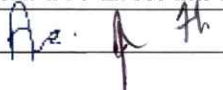
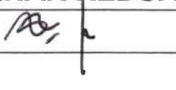
11. AIDS dan ARC (AIDS Related Complex) atau pengobatan yang berhubungan dengan Penyakit Kelamin serta akibat yang ditimbulkan.
12. Terapi Kosmetik, Terapi Disfungsi Seksual.

PASAL 6

PROSEDUR PELAYANAN KESEHATAN

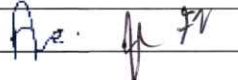
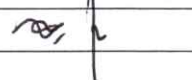
1. **PARA PIHAK** menyetujui prosedur pelayanan kesehatan Rawat Jalan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Peserta berkewajiban untuk menunjukkan Kartu Peserta atau E-card yang masih berlaku beserta Identitas Diri kepada petugas pendaftaran rawat jalan kepada **PIHAK KEDUA**. Kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Kerja Sama ini, apabila Peserta dengan alasan apapun tidak dapat menunjukkan Kartu Peserta maka Peserta tersebut akan diperlakukan sebagai pasien umum yang bukan merupakan tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**.
 - b. Petugas **PIHAK KEDUA** akan memeriksa Kartu Peserta atau E-Card dan hak Peserta berdasarkan manfaat asuransi kesehatan dari Peserta yang bersangkutan dan melakukan validasi melalui Aplikasi BRILIFE-Care.
 - c. Peserta akan menerima pelayanan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku.
 - d. Tagihan atas biaya pelayanan kesehatan tidak ditagihkan kepada Peserta, karena seluruh biaya yang timbul menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**, kecuali jika terdapat ekses, maka ekses tersebut wajib ditagih oleh **PIHAK KEDUA** sebelum Peserta meninggalkan Rumah Sakit **PIHAK KEDUA**.
 - e. Atas permintaan **PIHAK PERTAMA**, **PIHAK KEDUA** wajib memberikan keterangan medis secara tertulis mengenai Peserta. **PIHAK PERTAMA** dengan ini menyatakan bahwa **PIHAK PERTAMA** telah mendapatkan izin dan kuasa dari Peserta untuk meminta dan atau menerima keterangan medis baik secara lisan maupun tertulis dari **PIHAK KEDUA** mengenai kesehatan Peserta dan untuk itu **PIHAK PERTAMA** akan bertanggungjawab penuh atas keterangan medis yang telah disampaikan **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA**.

Hlm. 12 dari 37

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- f. **PIHAK KEDUA** wajib menolak permintaan Peserta untuk mengubah tanggal perawatan, Diagnosa, Pemeriksaan Tes Laboratorium dan Tes Diagnostic.
2. **PARA PIHAK** menyepakati prosedur pelayanan kesehatan Rawat Inap dengan ketentuan sebagai berikut:
- Peserta berkewajiban untuk menunjukkan Kartu Peserta atau E-card yang masih berlaku beserta Identitas Diri kepada petugas pendaftaran rawat inap di **PIHAK KEDUA**. Kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Kerja Sama ini, apabila Peserta dengan alasan apapun tidak dapat menunjukkan Kartu Peserta maka Peserta tersebut akan diperlakukan sebagai pasien umum yang bukan merupakan tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**.
 - Petugas **PIHAK KEDUA** akan memeriksa Kartu Peserta atau E-Card dan/atau Surat Jaminan dan melakukan konfirmasi mengenai validitas Kartu Peserta dan/atau Surat Jaminan dengan hak Peserta berdasarkan manfaat asuransi kesehatan atau kebijakan fasilitas kesehatan perusahaan dari Peserta melalui Aplikasi BRILIFE CARE.
 - PIHAK KEDUA** wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** dengan formulir Pelaporan (konfirmasi) Perawatan Peserta, paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak Peserta menjalani Rawat Inap.
 - PIHAK KEDUA** wajib memberitahukan secara tertulis atau melalui telpon kepada **PIHAK PERTAMA** dengan formulir pelaporan (konfirmasi) perawatan Peserta, paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak Peserta akan melakukan tindakan penunjang medis saat menjalani Rawat Jalan (misalnya: Tindakan BNO-IVP, CT-Scan) untuk mendapat persetujuan dari **PIHAK PERTAMA**.
 - PIHAK KEDUA** wajib memberitahukan secara tertulis atau melalui telepon kepada **PIHAK PERTAMA**, bila penggunaan **obat per item mencapai Rp. 500.000,-** (lima ratus ribu rupiah) dan pemakaian obat-obatan serta **pemeriksaan penunjang** dengan **total biaya lebih dari Rp. 1.000.000,-** (satu juta rupiah) untuk mendapat persetujuan dari **PIHAK PERTAMA**.
 - PIHAK KEDUA** dapat merujuk Peserta untuk dirawat ke Rumah Sakit lain, dalam hal terjadi kerusakan ataupun keterbatasan fasilitas dan kamar perawatan yang dimiliki oleh **PIHAK KEDUA**.
 - Apabila kamar yang menjadi hak Tertanggung penuh, maka Tertanggung dapat ditempatkan di kamar perawatan 1 (satu) tingkat lebih tinggi dari haknya maksimum

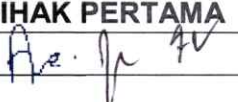
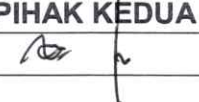
Hlm. 13 dari 37

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam dengan biaya ditanggung oleh **PIHAK PERTAMA**, dimana **PIHAK KEDUA** sebelumnya wajib melakukan pemberitahuan atau konfirmasi terlebih dahulu melalui telepon atau media komunikasi lainnya kepada **PIHAK PERTAMA** dan apabila keesokan harinya kamar yang sesuai dengan hak Peserta sudah tersedia, maka **PIHAK KEDUA** wajib memindahkan Peserta ke kamar yang sesuai haknya. Apabila setelah 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam, kamar yang seharusnya menjadi hak bertanggung masih belum tersedia, maka **PIHAK KEDUA** akan mengkonfirmasi kepada **PIHAK PERTAMA** mengenai hal tersebut apakah bertanggung akan dirujuk ke rumah sakit lain atau selisih biaya perawatan yang timbul menjadi beban bertanggung.

- h. Tagihan atas biaya pelayanan kesehatan tidak ditagihkan kepada Peserta, karena seluruh biaya yang timbul menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**, kecuali jika terdapat eksekusi, maka eksekusi tersebut wajib ditagih oleh **PIHAK KEDUA** sebelum Peserta meninggalkan Rumah Sakit **PIHAK KEDUA**.
 - i. **PIHAK KEDUA** wajib menolak permintaan Peserta untuk mengubah tanggal perawatan, diagnosa, pemeriksaan tes laboratorium dan tes diagnostic.
 - j. **PIHAK KEDUA** wajib menolak pemeriksaan yang secara medis tidak diperlukan dan tidak berhubungan dengan perawatan serta pemberian pelayanan kesehatan atas diri Peserta.
 - k. Apabila pada ayat i dan atau ayat j dalam pasal ini dilanggar maka **PIHAK PERTAMA** berhak memutuskan secara sepihak atas Perjanjian Kerja Sama ini.
 - l. Apabila ada tindakan/pemeriksaan yang memerlukan biaya besar, **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk mengkonfirmasi hal tersebut kepada **PIHAK PERTAMA**.
3. **PARA PIHAK** menyepakati prosedur pelayanan kesehatan COB BPJS KESEHATAN sebagai berikut :
- a. Pemberian pelayanan bagi Peserta sesuai dengan ketentuan/peraturan pelaksanaan sebagaimana telah diatur oleh Peraturan pemerintah/ perundang -undangan.
 - b. Peserta dilayani sesuai dengan alur dari BPJS Kesehatan dan ditawarkan untuk COB BPJS Kesehatan dengan cara **PIHAK PERTAMA** menanyakan kepada peserta **PIHAK KEDUA** apakah ada kartu peserta BRILIFE dan diinformasikan ke peserta bisa melayani COB BPJS Kesehatan.
 - c. Peserta wajib menunjukkan Kartu Peserta, Kartu Peserta BPJS Kesehatan dan surat rujukan dari FKTP (Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama) BPJS Kesehatan yang sah

Hlm. 14 dari 37

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- dan masih berlaku pada petugas pendaftaran rawat inap Rumah Sakit, dan menyerahkan fotokopi kartu peserta BPJS Kesehatan, Kartu Identitas Diri, Surat Rujukan dari FKTP (Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama) masing-masing 2 (dua) rangkap kepada petugas pendaftaran rawat inap Rumah Sakit. (jika diperlukan)
- d. Petugas Rumah Sakit akan memeriksa Kartu Peserta, Kartu Peserta BPJS Kesehatan, kartu identitas diri dan surat rujukan dari FKTP (Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama) dan melakukan konfirmasi mengenai validitas jaminan dan hak fasilitas pelayanan kesehatan yang dapat dipergunakan oleh Peserta. Peserta melengkapi persyaratan administrasi untuk penerbitan SEP maksimal 3 X 24 Jam sejak Peserta masuk Rumah Sakit/sebelum pasien pulang/ pasien meninggal dunia.
 - e. Petugas Rumah Sakit harus cross cek di system BPJS Kesehatan dan juga Sytem Aplikasi BRILIFE-Care, untuk kepesertaan apakah masih aktif atau tidaknya (Eligibility peserta).
 - f. BPJS Kesehatan sebagai penjamin pertama dan Perusahaan/Asuransi Kesehatan Tambahan lainnya merupakan penjamin kedua. Apabila biaya perawatan yang timbul melebihi batas santunan yang ditetapkan dalam polis Asuransi Kesehatan, maka *Selisih Biaya* yang terjadi wajib ditagih oleh **PIHAK KEDUA** sebelum Peserta meninggalkan Rumah Sakit **PIHAK KEDUA**.
 - g. Peserta wajib mengisi dan menandatangani formulir administrasi rawat inap yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA**.
 - h. Peserta yang menginginkan perawatan atau kelas rawat inap yang lebih tinggi dari hak nya harus membayar selisih biaya setiap episode rawat inap. Peserta dapat naik 2 (dua) kelas lebih tinggi dari hak kelas BPJS Kesehatan yang dimiliki. **PIHAK KEDUA** akan merawat Peserta sesuai standar pelayanan **PIHAK KEDUA** dan sesuai hak fasilitas pelayanan kesehatan yang didapat Peserta.
 - i. Peserta dengan hak kelas III tidak diperkenankan untuk naik kelas Rawat Inap. Apabila masih menginginkan naik kelas maka tidak berlaku penjaminan BPJS Kesehatan atau COB BPJS KESEHATAN.
 - j. Pasien tidak ditagih untuk membayar uang deposit bila surat jaminan sudah diserahkan. Semua biaya pelayanan kesehatan yang timbul menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar oleh **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan manfaat.
 - k. Selisih biaya yang terjadi akibat dari kenaikan kelas yang dikehendaki peserta dari hak BPJS Kesehatan yang dimiliki berlaku sesuai Peraturan Menteri Kesehatan No.3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan

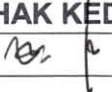
Hlm. 15 dari 37

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Program Jaminan Kesehatan, dimana **PIHAK PERTAMA** membayarkan selisih tarif **PIHAK KEDUA** dengan INA CBG.

- l. Selisih biaya yang terjadi menurut huruf i menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**
 - m. **PIHAK KEDUA** wajib memasukkan jumlah selisih pembayaran yang ditagihan ke **PIHAK PERTAMA** di Aplikasi **BRILIFE-Care**.
 - n. Apabila terjadi selisih setelah verifikasi oleh BPJS Kesehatan maka **PARA PIHAK** akan membicarakan selisih tersebut dengan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku pada kesepakatan **PARA PIHAK**.
4. Dalam hal **PIHAK KEDUA** menyediakan pelayanan *Telemedicine*, maka mekanisme pelayanan *Telemedicine* di **PIHAK KEDUA** sebagai berikut:
- a. Peserta akan menghubungi ruang *chat/call/video call* pada nomor/aplikasi yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA** untuk melakukan pendaftaran.
 - b. **PIHAK KEDUA** meneliti kelengkapan dan keabsahan Peserta dengan meminta Peserta mengirimkan foto kartu Peserta dan kartu identitas (KTP/SIM) untuk dilakukan validasi. Apabila berkas tidak lengkap, langsung diinformasikan ke Peserta untuk melengkapinya.
 - c. **PIHAK KEDUA** melakukan entri dan terbit Surat Jaminan Pelayanan *Telemedicine* secara *realtime* di Aplikasi **BRILIFE-Care**.
 - d. **PIHAK KEDUA** selanjutnya meng-*entry*, mencetak, memberikan pernyataan dan jaminan keaslian atas Surat Jaminan Pelayanan dengan syarat dan mekanisme setiap *entry* harus menggunakan Aplikasi **BRILIFE-Care** dan memilih Surat Jaminan Pelayanan *Telemedicine* serta login dengan username dan password yang sudah diberikan.
 - e. **PIHAK KEDUA** selanjutnya menerbitkan Surat Jaminan Pelayanan (SJP), kemudian ditandatangani oleh Petugas dan tidak mensyaratkan tanda tangan Peserta.
 - f. Peserta yang telah dinyatakan valid di Aplikasi **BRILIFE-Care** mendapatkan pelayanan *Telemedicine* yang ditindaklanjuti oleh **PIHAK KEDUA** dengan memilih dokter yang tersedia dan Peserta akan dihubungi oleh dokter **PIHAK KEDUA**.
 - g. **PIHAK KEDUA** akan merespon pesan Peserta paling lambat dalam 3 menit dan dokter **PIHAK KEDUA** akan menghubungi Peserta paling lambat dalam 3 menit sejak mendapat konfirmasi dari **PIHAK KEDUA**.
 - h. Setelah pelayanan *Telemedicine* selesai, dokter **PIHAK KEDUA** yang memberikan pelayanan kesehatan dan obat menuliskan diagnosa pada bukti kunjungan.

Hlm. 16 dari 37

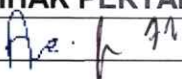
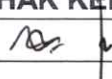
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

PASAL 7

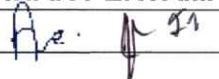
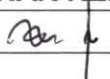
PEMBAYARAN ATAS JASA PELAYANAN KESEHATAN

1. Pengajuan tagihan pembayaran dari **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** dapat dilakukan dengan cara *online* .
2. Pengajuan tagihan pembayaran secara *online* sebagaimana dimaksud ayat (1) pada pasal ini dilakukan dengan cara **PIHAK KEDUA** mengunggah berkas *softcopy* melalui BRILIFE-Care.
3. Untuk tagihan Rawat Inap **PIHAK KEDUA** wajib melakukan pengiriman tagihan kepada **PIHAK PERTAMA** dan tagihan tersebut harus sudah diterima paling lambat 14 (Empat Belas) hari kalender untuk pengajuan klaim dengan cara *online* terhitung sejak Peserta keluar dari fasilitas pelayanan Rawat Inap **PIHAK KEDUA** dengan dilengkapi dokumen pendukung penagihan klaim sebagai berikut :
 - a. Foto Copy Kartu Peserta;
 - b. Foto Copy KTP yang bersangkutan
 - c. Formulir Rawat Inap yang ditandatangani Dokter yang merawat dan Peserta.
 - d. Surat Rujukan (jika ada)
 - e. Kuitansi Asli (bermeterai cukup).
 - f. Perincian Biaya Perawatan atas biaya-biaya dan Fasilitas Penunjang yang dipergunakan (Obat, Laboratorium dll).
 - g. Resume Medis.
 - h. **PIHAK KEDUA** dapat melakukan penutupan rekening (pengajuan klaim) bila jumlah biaya pengobatan mencapai $\pm$ Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) meskipun Peserta/ Nasabah/ Karyawan/ Keluarga belum meninggalkan rumah sakit.
4. Untuk tagihan Rawat Jalan **PIHAK KEDUA** wajib melakukan pengiriman tagihan kepada **PIHAK PERTAMA** dan tagihan tersebut harus sudah diterima 14 (empat belas) hari kalender baik pengajuan klaim dengan cara *online* terhitung sejak Peserta mendapatkan fasilitas pelayanan Rawat Jalan dari **PIHAK KEDUA** dengan dilengkapi dokumen pendukung penagihan klaim sebagai berikut:
 - a. Foto Copy Kartu Peserta.

Hlm. 17 dari 37

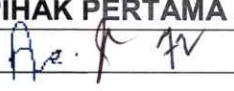
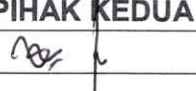
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- b. Formulir Rawat Jalan yang ditandatangani Dokter yang merawat dan Peserta.
 - c. Kuitansi Asli (bermeterai cukup).
 - d. LoA (Letter Of Authoritation) sesuai dengan Aplikasi BRILIFE-Care.
 - e. LoC (Letter Of Confirmation) sesuai dengan Aplikasi BRILIFE-Care.
 - f. Perincian Biaya Perawatan atas Biaya-biaya dan Fasilitas Penunjang yang dipergunakan (Obat, Laboratorium dll).
5. Untuk tagihan *Telemedecine* **PIHAK KEDUA** wajib melakukan pengiriman tagihan kepada **PIHAK PERTAMA** dan tagihan tersebut harus sudah diterima 14 (empat belas) hari kalender baik pengajuan klaim dengan cara *online* terhitung sejak Peserta mendapatkan fasilitas pelayanan *Telemedecine* dari **PIHAK KEDUA** dengan dilengkapi dokumen pendukung penagihan klaim sebagai berikut:
 - a. Foto kartu peserta diupload
 - b. Bukti Transaksi *online*
 - c. Perincian Biaya Pengobatan *online*
 - d. Kuitansi asli bermeterai yang diupload
6. Untuk tagihan COB BPJS **PIHAK KEDUA** wajib melakukan pengiriman tagihan kepada **PIHAK PERTAMA** dan tagihan tersebut harus sudah diterima paling lambat 14 (Empat Belas) hari kalender untuk pengajuan klaim dengan cara *online* terhitung sejak Peserta keluar dari fasilitas pelayanan COB BPJS dengan dilengkapi dokumen pendukung penagihan klaim sebagai berikut:
 - a. Surat penagihan;
 - b. Kuitansi legalisir;
 - c. Fotokopi SEP;
 - d. Fotokopi bukti print out data txt (Coding BPJS Kesehatan);
 - e. Fotokopi dokumen penunjang (pemeriksaan penunjang dll);
 - f. Formulir klaim dari dokter yang merawat dalam bentuk asli (jika ada);
 - g. Fotokopi perincian biaya;
 - h. Fotokopi surat jaminan;
 - i. Fotokopi resume catatan medis;
 - j. Fotokopi hasil laboratorium (jika ada);
 - k. Print out rincian obat (jika ada) surat Penagihan.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

7. Apabila Pasien menggunakan fasilitas kesehatan dari COB BPJS Kesehatan, maka ketentuan pembayarannya sebagai berikut:
 - a. Tagihan Pertama
Tagihan dibayarkan oleh BPJS Kesehatan sesuai ketentuan dalam BPJS Kesehatan
 - b. Tagihan Kedua
Tagihan selisih biaya yang tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan, maka ditagihkan kepada **PIHAK PERTAMA**, dengan tetap melampirkan seluruh rincian tagihan Pasien.
 - c. Tagihan Ketiga
Tagihan selisih biaya yang tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan dan **PIHAK PERTAMA**, maka akan ditagihkan langsung ke Peserta.
8. Bahwa dokumen-dokumen yang dimaksud dalam ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) wajib disampaikan berdasarkan tagihan (*invoice*) per-Peserta.
9. **PIHAK PERTAMA** wajib memberi tanggapan diterima atau ditolakannya dalam batas waktu 14 (empat belas) Hari Kerja sejak dokumen dari **PIHAK KEDUA** diterima **PIHAK PERTAMA** untuk diserahkan kembali ke **PIHAK KEDUA**. **PIHAK PERTAMA** wajib memberikan informasi alasan ditolaknya pengajuan tagihan pembayaran kepada **PIHAK KEDUA**.
10. Dalam hal pengajuan tagihan pembayaran ditolak sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) **PIHAK KEDUA** wajib melengkapi dokumen pengajuan tagihan pembayaran kepada **PIHAK PERTAMA** paling lambat 7 (tujuh) hari kalender.
11. Jika **PIHAK KEDUA** tidak melengkapi pengajuan tagihan pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (10) dalam batas waktu 14 (*Empat Belas*) hari kalender sejak surat informasi penolakan dari **PIHAK PENERIMA** diterima oleh **PIHAK KEDUA**, maka tagihan tersebut dianggap *Kedaluwarsa* dan **PIHAK PERTAMA** *dibebaskan dari kewajiban* pembayaran atas tagihan tersebut.
12. **PIHAK PERTAMA** melakukan pembayaran tagihan biaya **PIHAK KEDUA** tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tagihan **PIHAK KEDUA** diterima **PIHAK PERTAMA** tanpa tanggapan dan atau perubahan tagihan dalam 30 (Tiga Puluh) hari kerja setelah menerima tagihan, dengan mentransfer jumlah yang ditagih ke rekening **PIHAK KEDUA** pada :

Hlm. 19 dari 37

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

RS PRIMA HUSADA MALANG

Bank : PT. Bank Central Asia Tbk
 Kantor Cabang : KK Malang – Singosari
 No. Rekening : 368 - 3040700
 Atas Nama : PT. Disa Prima Medika
 No. NPWP : 21.137.072.1-657.000
 Nama Atas NPWP : PT. Disa Prima Medika

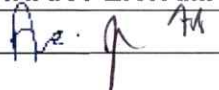
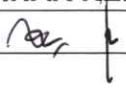
RS PRIMA HISADA SUKOREJO

Bank : PT. Bank Mandiri Persero Tbk
 Kantor Cabang : KK Malang – Sutoyo
 No. Rekening : 144-0055533324
 Atas Nama : PT. Disa Prima Medika
 No. NPWP : 21.137.072.1-657.000
 Nama Atas NPWP : PT. Disa Prima Medika

13. Dalam hal **PIHAK PERTAMA** terlambat dalam melakukan pembayaran tagihan klaim pelayanan kesehatan, maka **PIHAK PERTAMA** akan melakukan pembayaran denda kepada **PIHAK KEDUA** sebesar 5 % (satu persen) dari jumlah yang harus dibayarkan untuk setiap 1 (satu) bulan keterlambatan secara proporsional, setelah **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK PERTAMA** melakukan 2 (dua) kali korespondensi secara tertulis, dengan catatan 2 (dua) kali korespondensi dilakukan dengan jeda waktu diantaranya adalah 5 hari kerja dari korespondensi yang pertama ke korespondensi yang kedua.
14. Apabila **PIHAK KEDUA** lalai dalam mengajukan tagihan kepada **PIHAK PERTAMA** sesuai batas waktu penagihan yaitu 30 (*Tiga Puluh*) hari kalender setelah pasien keluar Rawat Inap dan Rawat Jalan maka tagihan tersebut dianggap *Kedaluwarsa* dan **PIHAK PERTAMA** *dibebaskan dari kewajiban* pembayaran atas tagihan tersebut.
15. **PIHAK KEDUA** sepakat memberikan *discount* atau potongan harga untuk seluruh pelayanan kesehatan sebesar 1% dari seluruh total tagihan yang akan langsung dikurangi di dalam total tagihan dan masuk dalam system **PIHAK KEDUA**.

PASAL 8
CONTACT PERSON

Hlm. 20 dari 37

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

1. Bahwa setiap Surat menyurat, Pemberitahuan, Permintaan, Persetujuan, Perubahan, Keluhan-keluhan dan lain-lainnya sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini, dilakukan secara tertulis dan dapat disampaikan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya melalui *contact person* yang ditunjuk oleh **PARA PIHAK** untuk menangani/ menindaklanjuti permasalahan/ komplain/ keluhan tersebut ke alamat sebagai berikut:

Contact person sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah:

PIHAK PERTAMA:

Contact Person untuk Perjanjian Kerja Sama, menghubungi:

Nama : Ade Wijayanti
 Unit Kerja : *Provider Relation*
 No. Hp : 087770070078
 Email : ade.wijayanti@brilife.co.id

Nama : dr. RR Almira Dhanie, MARS
 Unit Kerja : *Provider Relation*
 No. Hp : 082260843566
 Email : almira.dhanie@brilife.co.id

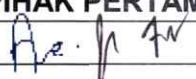
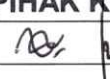
Nama : Susi
 Unit Kerja : *Provider Relation*
 No. Hp : 081776672602
 Email : susi@brilife.co.id

Alamat PKS : **Gedung Graha Irama**
Jl. HR. Rasuna Said Blok X1 Kav.1-2
Kuningan, Jakarta Selatan, 12950

Contact Person untuk Pelayanan Kesehatan/Jaminan peserta menghubungi **Pelayanan 24 Jam** dinomor:

Call Center/Penjaminan : 150187

Hlm. 21 dari 37

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Email : contact.center@brilife.co.id

Contact Person klaim tagihan dan Konfirmasi Pembayaran, menghubungi:

Nama : **Up. Klaim Tagihan Provider**

Email : invoice@brilife.co.id

RS Prima Husada Malang

Contact person untuk Perjanjian Kerja Sama, menghubungi:

Nama : Mayputri Nabilla A.Md.Kes.

Unit Kerja : Humas dan Marketing

No. Telp. : 0811 3507 164

No. Fax. : -

Email : marketingrsphm@gmail.com

Alamat : Jl. Banjararum Selatan No. 3-9 Mondoroko
Kec. Singosari, Kab. Malang

Contact person untuk Pelayanan Kesehatan, menghubungi:

Nama : Daning Pravitia AMD,Keb

Unit Kerja : Pelayanan Medis/ Manager On Duty

No. Telp. : 0811 3110 3113

No. Fax. : -

Contact person untuk Kelengkapan Berkas Tagihan dan Konfirmasi Pembayaran, menghubungi:

Nama : Lilik Kurniati

Unit Kerja : Admin Jaminan Asuransi Rawat Jalan &Rawat Inap

No. Telp. : 081331429720

No. Fax. : -

Email : admklaim.rsph@gmail.com

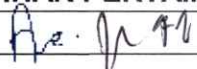
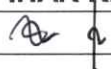
RS Prima Husada Sukorejo

Contact person untuk Perjanjian Kerja Sama, menghubungi :

Nama : Rizqi Gitari Fernanda, A. Md. Kep

Unit Kerja : Humas dan Marketing

Hlm. 22 dari 37

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

No. Telp. : 081315574065
 No. Fax. : -
 Email : backupdatamarketingphs@gmail.com
 Alamat : Jl. Raya Surabaya – Malang KM. 54
 Desa Lemahbang, Kec. Sukorejo, Kab. Pasuruan

Contact person untuk Pelayanan Kesehatan, menghubungi:

Nama : Nur Aini Izzah, S.Kep., Ns
 Unit Kerja : Pelayanan Medis/ Manager On Duty
 No. Telp. : 0811 3031 885
 No. Fax. : -

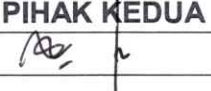
Contact person untuk Kelengkapan Berkas Tagihan dan Konfirmasi Pembayaran, menghubungi:

Nama : Prisna Sandy Faradilla
 Unit Kerja : Admin Jaminan Asuransi Rawat Jalan & Rawat Inap
 No. Telp. : 0821 4203 6398
 No. Fax. : -
 Email : keuanganrsphs@gmail.com

2. Bilamana terjadi perubahan alamat dan/atau nomor rekening **PARA PIHAK**, maka pihak yang alamat dan/ atau nomor rekeningnya berubah wajib memberitahukannya secara tertulis kepada yang lain selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum perubahan tersebut.
3. Segala resiko dan kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat kelalaian dalam memberitahukan perihal perubahan alamat dan/ atau nomor rekening dalam batas waktu tersebut diatas akan menjadi tanggungan pihak yang mengalami perubahan alamat dan/ atau nomor rekening.

PASAL 9
FORCE MAJEURE

Hlm. 23 dari 37

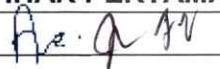
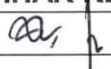
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

1. **PARA PIHAK** Wajib untuk melaksanakan seluruh ketentuan – ketentuan yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerja Sama ini kecuali dalam hal terjadinya *Force Majeure* yang menyebabkan terhentinya atau tertundanya Perjanjian Kerja Sama ini.
2. Keadaan *Force Majeure* adalah segala keadaan atau peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan **PARA PIHAK**, seperti bencana alam, sabotase, pemogokan, huru – hara, *epidemic*, kebakaran, banjir, gempa bumi, perang, Keputusan Pemerintah atau instansi yang berwenang, yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya Perjanjian Kerja Sama ini.
3. Setiap kejadian yang bersifat *Force Majeure* harus diberitahukan kepada Pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya *Force Majeure*. Dengan surat pemberitahuan yang disertai dengan keterangan resmi dari Pejabat Pemerintah setempat yang berwenang.
4. Tidak adanya pemberitahuan hingga lewatnya waktu sebagaimana ditentukan dalam ayat (3) Pasal ini, mengakibatkan Pihak yang lain yang tidak mengalami peristiwa *Force Majeure* berhak untuk tidak mengakui adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut.
5. Biaya biaya yang timbul dan diderita oleh pihak yang mengalami *Force Majeure* bukan merupakan tanggung jawab Pihak lainnya.
6. Pihak yang mengalami *Force Majeure* harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama ini paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah *Force Majeure* tersebut berakhir.
7. Keadaan *Force Majeure* yang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan Perjanjian Kerja Sama akan tetapi hanya merupakan keadaan yang menangguhkan Perjanjian Kerja Sama sampai keadaan *Force Majeure* berakhir.
8. Apabila keadaan *Force Majeure* berlangsung berlarut larut lebih dari 30 (tiga puluh) hari kalender, maka salah satu Pihak dapat menghentikan Perjanjian Kerja Sama secara sepihak dengan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lain.

PASAL 10

KETENTUAN TENTANG KORUPSI DAN PENYUAPAN

Hlm. 24 dari 37

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

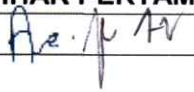
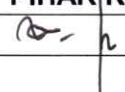
1. **PARA PIHAK** tidak melakukan, memberikan kuasa atau mengizinkan tindakan yang menyebabkan **PARA PIHAK** dan/atau afiliasinya melakukan segala perbuatan yang melanggar hukum yang diatur dalam undang-undang anti korupsi dan/atau peraturan lain yang berlaku. Kewajiban ini berlaku khususnya untuk pembayaran yang tidak sah kepada pejabat pemerintah, wakil-wakil otoritas publik, rekan-rekan **PARA PIHAK**, keluarga atau teman dekat.
2. **PARA PIHAK** setuju bahwa tidak akan menawarkan atau memberi atau setuju untuk memberi kepada karyawan, setiap perwakilan atau pihak ketiga yang bertindak atas nama pihak lain atau menerima atau menyetujui untuk menerima dari setiap karyawan, perwakilan atau pihak ketiga yang bertindak atas nama pihak lain, hadiah atau manfaat baik berupa uang atau lainnya yang mana penerima menurut hukum bukanlah pihak yang berhak sehubungan dengan negosiasi, hasil, atau pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
3. **PARA PIHAK** wajib segera memberitahukan satu sama lain, jika terjadi kecurigaan adanya tindakan korupsi berkaitan dengan hasil negosiasi atau pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
4. **PARA PIHAK** dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini apabila terdapat pembayaran atau pemberian hadiah yang tidak wajar yang dilakukan oleh salah satu pihak sebagaimana disebutkan dalam Perjanjian Kerja Sama ini atau jika salah satu pihak memiliki alasan untuk meyakini bahwa pembayaran atau pemberian hadiah tersebut dilakukan oleh pihak lainnya, hal mana harus dibuktikan terlebih dahulu.

PASAL 11

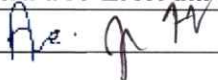
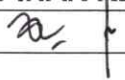
PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME DI SEKTOR JASA KEUANGAN

PARA PIHAK berkewajiban untuk menerapkan hal-hal yang berkaitan dengan nasabah sehubungan dengan Pelaksanaan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan dan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila **PARA PIHAK** maupun pejabat yang berwenang meminta informasi yang berkaitan dengan program APU dan PPT tersebut, maka **PARA PIHAK** berkewajiban memberikan data-data yang berkaitan dengan program APU dan PPT tersebut dengan

Hlm. 25 dari 37

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

ketentuan bahwa permintaan atas informasi nasabah tersebut harus dibuat secara tertulis oleh Pihak yang meminta informasi.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

PASAL 12**JANGKA WAKTU DAN BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJA SAMA**

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (*Lima*) tahun terhitung mulai tanggal **28 Febuari 2025 s/d 27 Febuari 2029**.
2. Salah satu Pihak atau **PARA PIHAK** berhak mengakhiri Perjanjian Kerja Sama. Bagi Pihak yang menginginkan berakhirnya Perjanjian Kerja Sama berkewajiban menyampaikan secara tertulis kepada pihak lain sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian Kerja Sama yang diinginkan.
3. Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini berakhir tidak membebaskan **PARA PIHAK** untuk memenuhi kewajiban yang belum diselesaikan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.
4. Bila pada saat Perjanjian Kerja Sama ini berakhir karena sebab-sebab yang diatur dalam Pasal 7 ayat (6) dan pada saat itu masih ada Peserta yang berada dalam perawatan Jalan di Rumah Sakit **PIHAK KEDUA** maka Peserta tersebut tetap mendapat pelayanan kesehatan dari **PIHAK KEDUA** sampai selesai dan dipulangkan; sesuai batasan etika kedokteran dan etika rumah sakit; dan **PIHAK PERTAMA** mengikatkan dirinya serta bertanggung jawab penuh untuk membayar biaya pelayanan kesehatan Peserta kepada **PIHAK KEDUA** sesuai aturan-aturan yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerja Sama ini

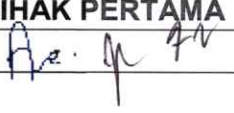
PASAL 13**EVALUASI**

PARA PIHAK menyepakati untuk melakukan evaluasi sekurang-kurangnya satu kali (1 x) sekali setiap tahunnya sejak Perjanjian Kerja Sama ini berlaku yang harus disepakati secara tertulis dalam lembar berita acara.

PASAL 14**ADDENDUM**

1. Perjanjian Kerja Sama hanya dapat diubah, diperbaiki, ditambah, diperbaharui atas persetujuan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam suatu dokumen tertulis yang dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, yang merupakan satu kesatuan

Hlm. 27 dari 37

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

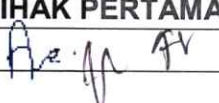
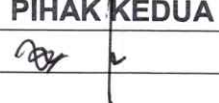
dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

2. Pihak yang menghendaki perubahan **Perjanjian Kerja Sama** ini harus mengajukan permohonan atau memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya guna dilakukan pembicaraan dan pembahasan untuk mencapai mufakat.
3. Hal-hal lain yang belum atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini maupun perubahan yang perlu dilakukan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam suatu dokumen tertulis yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 15 **KERAHASIAAN**

1. **PARA PIHAK** sepakat dan setuju bahwa segala data dan informasi, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis dan informasi-informasi lain yang berkaitan dengan bisnis, produk dan pelayanan yang diketahui atau timbul berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini adalah bersifat rahasia serta tidak boleh diberitahukan kepada pihak ketiga atau badan/orang lain yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun juga selama dan sesuai Perjanjian Kerja Sama ini.
2. **PARA PIHAK** sepakat untuk tidak membocorkan dan/ atau mempergunakan untuk kepentingan sendiri maupun pihak ketiga segala bentuk informasi, baik berupa data, system kerja, dokumen dan pengetahuan dalam bentuk apapun yang diperoleh berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini tanpa persetujuan tertulis dari Pihak lainnya.
3. **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk menjaga kerahasiaan mengenai Perjanjian Kerja Sama, semua data dan Informasi serta segala bentuk informasi lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
4. Akses atas informasi rahasia harus dibatasi hanya berlaku terbatas bagi pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
5. Ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud Pasal ini berlaku dan mengikat **PARA PIHAK** selama berlangsungnya Perjanjian kerjasama dan tetap berlaku serta mengikat **PARA PIHAK** meskipun Perjanjian Kerja Sama telah berakhir.

Hlm. 28 dari 37

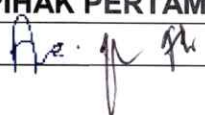
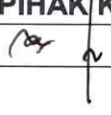
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

PASAL 16
SANKSI

PARA PIHAK mengakui bahwa setiap pelanggaran terhadap Perjanjian Kerja Sama ini dapat menyebabkan kerugian yang tidak dapat diperbaiki dimana ganti rugi dalam bentuk uang tidak mencukupi dan oleh karena itu, atas pelanggaran apa pun terhadap Perjanjian Kerja Sama ini, **PIHAK** yang tidak melanggar berhak untuk meminta ganti rugi yang adil, termasuk perintah dan kinerja khusus, sebagai pemulihan untuk setiap pelanggaran tersebut. Upaya pemulihan tersebut tidak akan dianggap sebagai solusi eksklusif untuk pelanggaran Perjanjian Kerja Sama ini, tetapi akan menjadi tambahan untuk semua upaya hukum lain yang tersedia menurut hukum atau keadilan bagi **PIHAK** yang tidak melanggar.

PASAL 17
PELINDUNGAN DATA PRIBADI

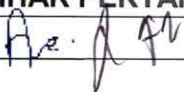
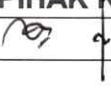
- 1. Bahwa tidak terlepas dari Pasal 15 tentang Kerahasiaan diperlukan ketentuan khusus mengenai Pelindungan Data Pribadi yang menjadi kewajiban **PARA PIHAK** sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
- 2. Bahwa **PARA PIHAK** hanya akan melakukan Pemrosesan Data Pribadi Peserta Pertanggungans sesuai dengan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini.
- 3. **PARA PIHAK** hanya akan mengungkapkan Data Pribadi Peserta Pertanggungans kepada karyawannya atau agen atau subkontraktornya yang tunduk pada kewajiban kerahasiaan yang mengikat sehubungan dengan Data Pribadi.
- 4. **PARA PIHAK** hanya akan menyediakan Data Pribadi Peserta Pertanggungans kepada personel yang memerlukan akses ke Data Pribadi tersebut untuk memberikan layanan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini.
- 5. **PARA PIHAK** harus menerapkan langkah-langkah teknis dan organisasi yang sesuai untuk memastikan tingkat keamanan yang sesuai dengan risiko untuk melindungi Data Pribadi dari kehilangan, kehancuran, atau kerusakan dan setiap Pemrosesan yang tidak sah atau melanggar hukum.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- 6. Apabila **PARA PIHAK** menerima permintaan dari Peserta Pertanggung jawaban yang menggunakan haknya berdasarkan hukum atau peraturan yang berlaku, maka **PARA PIHAK** harus memenuhi hak tersebut.
- 7. **PARA PIHAK** harus saling segera memberitahukan satu sama lain mengenai Pelanggaran Data Pribadi atau diterimanya pemberitahuan dari Otoritas Pengawas.
- 8. **PARA PIHAK** harus melakukan upaya yang wajar untuk mengidentifikasi penyebab Pelanggaran Data Pribadi tersebut dan mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu untuk menentukan penyebabnya dan untuk mencegah Pelanggaran Data Pribadi tersebut terulang kembali.
- 9. Selama jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** satu sama lain harus menyediakan semua informasi yang relevan yang secara wajar diperlukan untuk menunjukkan kepatuhan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini dan hukum atau peraturan yang berlaku, dan harus mengizinkan dan bekerja sama secara wajar dengan audit, termasuk inspeksi.

PASAL 18
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 1. Perjanjian Kerja Sama ini diatur dan tunduk pada hukum serta hanya dapat ditafsirkan menurut dan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- 2. Perselisihan yang timbul dari Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mencapai mufakat dalam waktu maksimal 30 hari (kalender).
- 3. Apabila dalam waktu sebagaimana ayat (2) diatas **PARA PIHAK** tidak berhasil menyelesaikan perselisihan yang timbul secara musyawarah untuk mencapai mufakat, maka **PARA PIHAK** setuju untuk menempuh penyelesaian melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
- 4. Untuk Perjanjian Kerja Sama ini dan segala akibatnya, **PARA PIHAK** sepakat untuk memilih tempat kedudukan hukum (domisili) yang tetap pada Kantor Kepaniteraan **Pengadilan Negeri Jakarta Selatan**.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

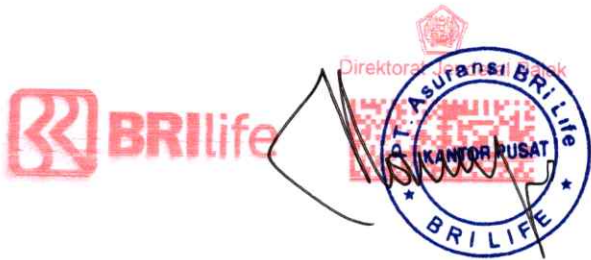
PASAL 19
LAIN-LAIN

- 1. **PARA PIHAK** sepakat bekerja sama dengan didasarkan pada itikad baik dan akan memenuhi semua kewajiban berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini.
- 2. Perjanjian Kerja Sama ini disertai dengan lampiran-lampiran yang merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini serta mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sebagaimana halnya Perjanjian Kerja Sama.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini telah disepakati dan ditandatangani, dibuat dalam 2 (dua) rangkap, bermaterai cukup dan masing-masing dipegang oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA
PT ASURANSI BRI LIFE

PIHAK KEDUA
PT DISA PRIMA MEDIKA



Anna Novy Handayani
Kepala Project Healthcare

METERAI TERAAN
15.12.2025
Rp 010000
E8B6 00244867
ID200198

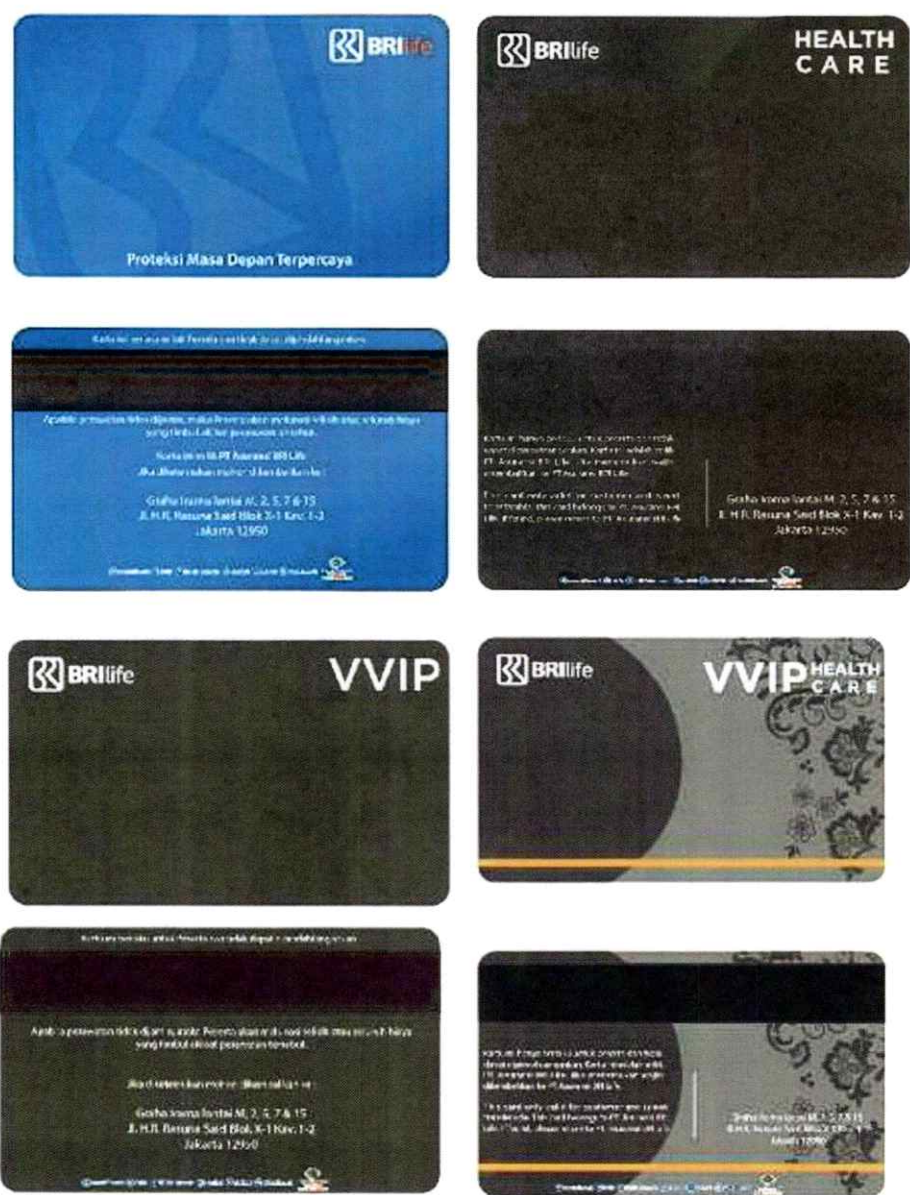


dr. Sefrina Trisadi, Sp. DVE
Direktur

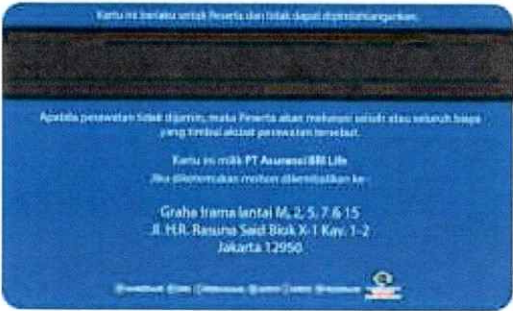
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

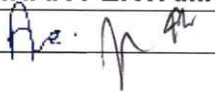
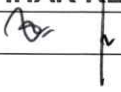
LAMPIRAN I

KARTU PESERTA ASURANSI KESEHATAN
PT. ASURANSI BRI LIFE



PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA



PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

LAMPIRAN II

LOA



RS MCSYS MEDIKA
JALAN JAPAT
NONE
MID :

Nama Peserta : Datuk sipatoka
No Kartu : 7137209000311541
Tanggal Lahir : 18-09-1992
No Polis : 31317
Masa Polis : (01-01-2020 s/d 31-12-2028)
Klien : PT. MCSYS INDEMNITY

****PENDAFTARAN PASIEN OUTPATIENT****
****INFORMASI BENEFIT****

1.	DOKTER & OBAT	20,000
2.	KB	500,000
3.	IMUNISASI DEWASA (DIATAS 12 TAHUN)	500,000
4.	KONSULTASI DOKTER UMUM	150,000
5.	KONSULTASI DOKTER SPESIALIS	SESUAI TGHN
6.	PERAWATAN GUSI	200,000

****CATATAN** :**
karyawan baru belum mengerti aplikasi jadi minta kami bantu

- EXCESS DIBAYAR DITEMPAT.
- ADMIN DIJAMIN DLM JASA DOKTER.
- VIT/SUPP SESUAI DIAGN, BUKAN OBAT UTAMA.
- BCG,DPT,POLIO,CAMPAK,HIB, MMR (<5 THN).
- FLU,HEP A,HEP B,THYPM,VARICELA (<5 THN).
- INFEKSI GENETALIA&INFERTIL TDK DIJAMIN.
- KNTRL HAMIL ANAK >3 & USG4D TDK DIJAMIN.
- GOL PELEMBAB & NON MEDIS TIDAK DIJAMIN.
- HAK KAMAR 1000

2023/11/15

.....TTD.....
Re-Print



PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

LOC



RS MCSYS MEDIKA
JALAN JAPAT
NONE
MID :

Nama Peserta : Datuk sipatoka
No Kartu : 7137209000311541
Tanggal Lahir : 18-09-1992
No Polis : 202009911M0011
Masa Polis : (01-01-2020 s/d 31-12-2028)

****BIAYA PELAYANAN RAWAT JALAN****
ICD10 : Z22.0
IZIN SAKIT : 0

****DIBAYAR ASURANSI****

1. DOKTER &	Rp.	undefined
2. OBAT	Rp.	20.000.00
3. KONSULTASI DOKTER UMUM	Rp.	150.000.00
TOTAL	Rp.	170.000.00

****DIBAYAR PESERTA****

1. DOKTER &	Rp.	undefined
2. OBAT	Rp.	280.000.00
3. KONSULTASI DOKTER UMUM	Rp.	250.000.00
TOTAL	Rp.	530.000.00

****CATATAN** :**
karyawan baru belum mengerti aplikasi jadi minta kami bantu

2023/11/15

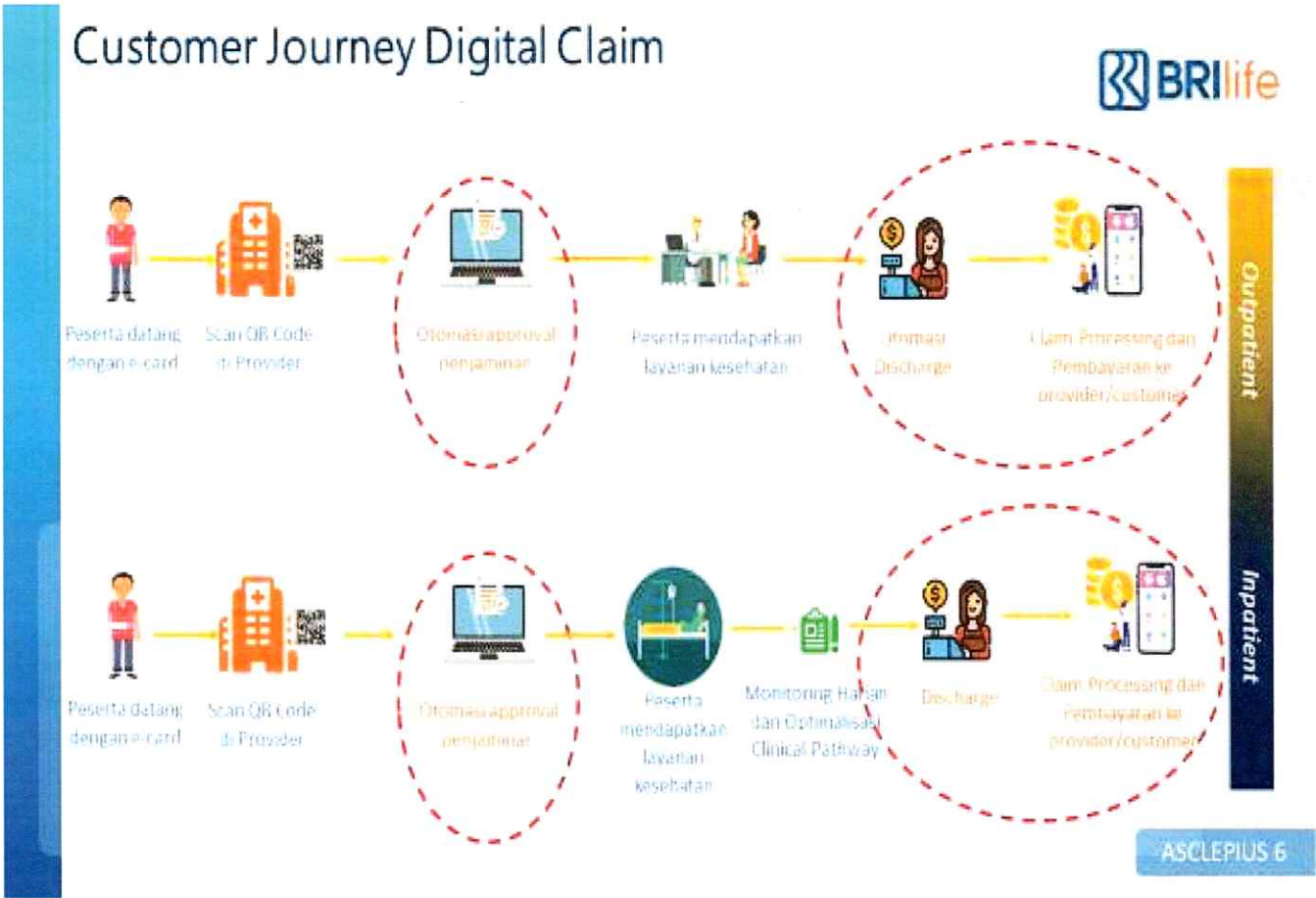
.....:TTD.....
Re-Print



PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

LAMPIRAN III

PROSEDUR LAYANAN PESERTA BRILIFE



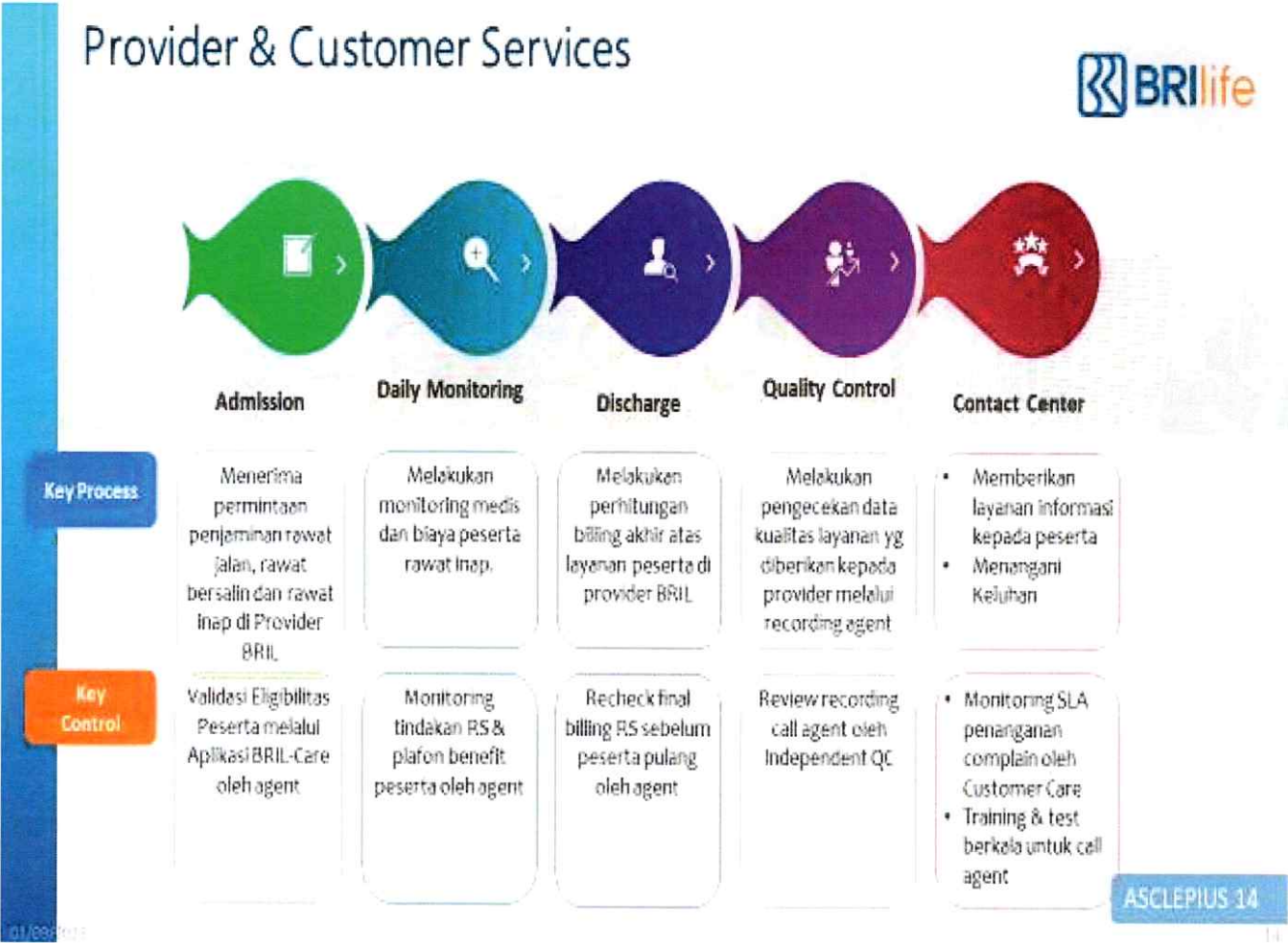
Catatan :

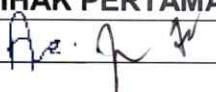
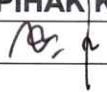
Penjaminan dapat dilakukan dengan cara : Scan Barcode atau menunjukkan kartu fisik yang akan dimasukkan dalam Aplikasi BRILIFE-Care

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

LAMPIRAN IV

ALUR PELAYANAN INTERNAL PIHAK PERTAMA



PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PT ASURANSI BRI LIFE
DENGAN
PT. DISA PRIMA MEDIKA
TENTANG
PELAYANAN KESEHATAN SECARA BERLANGGANAN**

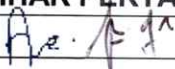
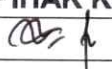
Nomor: B. 892/PMO/PHC/II/2025

Nomor: 046.4/DPM/E-PKS/DIR/II/2025

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat pada hari ini **Jumat**, tanggal **Dua Puluh Delapan** Bulan **Februari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** bertempat di **Jakarta** oleh dan antara :

1. **Anna Novy Handayani** jabatan **Kepala Project Healthcare**, Berdasarkan Akta Pendirian Nomor: 116 tanggal 28 Oktober 1987, Akta Nyonya Poerbaningsih Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta, disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: C2-6645.HT.01.01-TH.88 tanggal 2 Agustus 1988, dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 71 Tanggal 04 September 1990, Anggaran Dasar telah mengalami beberapa kali perubahan, Akta Nomor: 8 tanggal 2 Maret 2021, yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, SH., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan, disahkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0013073.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 2 Maret 2021, perubahan terakhir perubahan terakhir Akta Nomor: 11 tanggal 11 Maret 2023, yang dibuat oleh notaris Jose Dima Satria, SH., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan, disahkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03.0033868 tanggal 2 Maret 2023 **perubahan terakhir Akta No. 25 tanggal 8 Juni 2023 yang dibuat oleh Notaris Jose Dima Satria, SH., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan, disahkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0033982.AH.01.02 Tahun 2023, dan berdasarkan Surat Kuasa No ...** oleh karena itu sah menurut hukum bertindak untuk dan atas, oleh karena itu sah menurut hukum bertindak untuk dan atas nama PT Asuransi BRI Life, berkedudukan di Gedung Graha Irama Lantai 5, 7, dan 15, Jalan H.R Rasuna Said Blok X-1 Kav. 1&2 Jakarta Selatan Kode Pos 12950, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

Hlm. 1 dari 37

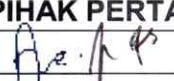
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

2. **dr. Sefrina Trisadi, Sp. DVE** sebagai Direktur **PT. DISA PRIMA MEDIKA** didirikan berdasarkan Akta nomor 26, tanggal 28 (Dua Puluh Delapan) 11 (November) 2009 (Dua Ribu Sembilan), dibuat dihadapan Endang Merduwati, S.H , Sarjana Hukum, Notaris di Kota Malang, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya Nomor AHU-63604.AH.01.01.Tahun 2009 tertanggal 31 (Tiga Puluh Satu) 12 (Desember) 2009 (Dua Ribu Sembilan) serta yang telah diumumkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS) Perseroan Terbatas PT. Disa Prima Medika No. 10 tanggal 16 (Enam Belas) 10 (Oktober) 2018 (Dua Ribu Delapan Belas) yang dibuat di hadapan Yudo Sigit Riswanto, SH., Sarjana Hukum, Notaris di Kota Malang, selaku Badan Usaha pengelola Rumah Sakit :
 - a. **Rumah Sakit Prima Husada Malang** dengan Izin Operasional Rumah Sakit No.81201150815810001 tertanggal 17 Mei 2022 diwakili oleh dr. Nur mazidah sebagai Direktur Rumah Sakit Prima Husada yang beralamat di Jl. Banjararum Selatan No. 3 – 7 Kecamatan Singosari Kabupaten Malang.
 - b. **Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo** dengan Izin Operasional Rumah Sakit No 81201150810004 tertanggal 20 September 2023 diwakili oleh Ns. Heni Indra Wulansari, S. Kep., M. Kep sebagai PLT Direktur Rumah Sakit Prima Husada yang beralamat di Jl. Raya Surabaya –Malang Km 54, Desa Lemahbang Kecamatan Sukorejo – Pasuruan selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri sendiri disebut **PIHAK**, menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah perusahaan asuransi jiwa dalam Perjanjian Kerja Sama ini menjamin biaya pelayanan kesehatan para Peserta **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan Polis Asuransi.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Rumah Sakit Swasta yang merupakan Rumah Sakit Grup dan oleh karena itu menyatakan berhak dan berwenang mewakili seluruh cabang/anak perusahaan di bawah kendali **PIHAK KEDUA**.
3. Bahwa oleh karena itu **PIHAK PERTAMA** bekerja sama dengan **PIHAK KEDUA** untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada Peserta **PIHAK PERTAMA**.

Hlm. 2 dari 37

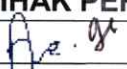
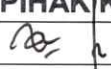
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas **PARA PIHAK** sepakat mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pelayanan Kesehatan Secara Berlangganan untuk selanjutnya disebut "**Perjanjian Kerja Sama**" dengan ketentuan yang diatur berdasarkan ketentuan-ketentuan dibawah ini:

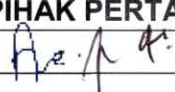
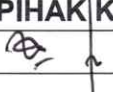
PASAL 1 PENGERTIAN

1. **Peserta** adalah pihak yang menjadi tanggungan **PIHAK PERTAMA** yang memenuhi syarat pertanggungan sebagaimana diatur dalam Polis Asuransi yang juga merupakan **Pasien**.
2. **Pasien** adalah setiap orang yang memperoleh Pelayanan Kesehatan dari **PIHAK KEDUA**.
3. **Pelayanan Kesehatan** adalah layanan kesehatan yang diberikan oleh Rumah Sakit kepada Peserta/ Tertanggung sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan kesehatan dan rumah sakit, termasuk tetapi tidak terbatas pada Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang terdiri antara lain Layanan Kesehatan Rawat Inap dan/ atau Layanan Kesehatan Rawat Jalan dan/ atau Layanan Gawat Darurat dan Observasi 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam.
4. **Rawat Jalan** adalah semua jasa Pelayanan Kesehatan yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA** kepada Pasien di rumah sakit **PIHAK KEDUA** dalam upaya perawatan/ atau pengobatan atau pemulihan kesehatan dimana Pasien tidak perlu menginap di Rumah Sakit **PIHAK KEDUA**.
5. **Rawat Inap** adalah semua jasa Pelayanan Kesehatan yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA** kepada Pasien di rumah sakit **PIHAK KEDUA** dalam upaya perawatan dan/ atau pengobatan atau pemulihan kesehatan dimana Pasien perlu menginap di rumah sakit **PIHAK KEDUA** atau paling sedikit observasi selama lebih dari 8 (delapan) jam. Dalam hal Pembedahan yang tidak memerlukan Rawat Inap, jangka waktu 8 (delapan) jam tersebut tidak berlaku.
6. **One Day Care** adalah layanan kesehatan berupa tindakan medis tertentu yang dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) hari kalender tanpa Rawat Inap.

Hlm. 3 dari 37

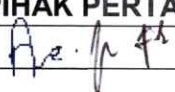
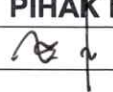
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

7. **Gawat Darurat** adalah tindakan medis yang harus diberikan sebagai pertolongan pertama untuk mengatasi keadaan darurat pada Pasien yang dilakukan di UGD (unit Gawat Darurat) pada rumah sakit **PIHAK KEDUA**.
8. **Surat Jaminan Pelayanan** adalah surat yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari **PIHAK PERTAMA** yang mencantumkan data-data Pasien dan batasan biaya (*Plafond*) perawatannya, untuk dipergunakan sebagai pengantar bagi Pasien guna memperoleh Pelayanan Kesehatan dari **PIHAK KEDUA**, serta merupakan jaminan pembayaran dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** atas Pelayanan Kesehatan yang telah diberikan oleh **PIHAK KEDUA**.
9. **Fasilitas Pelayanan Kesehatan** adalah sarana dan pra-sarana yang dipergunakan untuk Rawat Inap, Rawat Jalan dan Gawat Darurat yang meliputi pemeriksaan kesehatan, pengobatan, penggunaan obat-obat farmasi, penggunaan alat-alat kesehatan, pemeriksaan penunjang medis, penggunaan alat-alat penunjang medis atau tindakan medis yang dianggap perlu oleh dokter umum atau dokter spesialis.
10. **Rumah Sakit Lain** adalah rumah sakit yang merupakan fasilitas rujukan dari dokter yang merawat Pasien.
11. **Aplikasi BRILIFE-Care** adalah sistem informasi milik **PIHAK PERTAMA** yang diakses dan digunakan oleh **PIHAK KEDUA** untuk pelayanan kesehatan di **PIHAK KEDUA** mulai dari tahap awal pelayanan hingga tahap penagihan Klaim;
12. **Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan** yang selanjutnya disingkat **BPJS Kesehatan** adalah Badan hukum publik yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN);
13. **Bahan dan Alat Kesehatan Habis Pakai (BAHP)** adalah bahan dan alat kesehatan yang digunakan oleh **PIHAK KEDUA** dalam rangka melakukan diagnosa, pengobatan, dan perawatan yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA**;
14. **Berkas Elektronik** adalah berkas/dokumen pengajuan Klaim berupa *hardcopy*/berkas fisik yang dialihmediakan kedalam bentuk elektronik (*softcopy*) yang diajukan oleh **PIHAK KEDUA** melalui Aplikasi BRILIFE-Care;

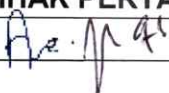
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

15. **Formularium Rumah Sakit** adalah obat yang pengadaannya dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** dan diresepkan oleh dokter **PIHAK KEDUA** kepada Peserta disesuaikan dengan kebutuhan peserta **PIHAK PERTAMA** dengan batasan manfaat secara wajar dan atau tidak berlebihan (terkendali).
16. **Hari Kalender** adalah setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender masehi ;
17. **Hari Kerja** adalah hari selain hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional
18. **Hari Rawat** adalah perhitungan jumlah Hari Rawat Inap Peserta di **PIHAK KEDUA** yaitu: dimulai dari tanggal masuk sampai dengan tanggal keluar dengan ketentuan apabila tanggal keluar sama dengan tanggal masuk, maka dihitung sebagai 1 (satu) Hari Rawat inap atau perhitungan rawat inap lain yang disepakati antara **PARA PIHAK** secara kasus per kasus;
19. **Indonesian-Case Based Group (INA-CBG)** adalah tarif klaim yang ditetapkan oleh BPJS Kesehatan kepada fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan atas paket pelayanan kesehatan yang didasarkan kepada pengelompokan diagnosis penyakit dan prosedur;
20. **Aplikasi INA CBG** adalah System yang digunakan oleh BPJS Kesehatan ke seluruh Rekanan Provider BPJS Kesehatan
21. **Jenis Pelayanan (Jenpel)** adalah daftar pelayanan kesehatan dan tarif kesepakatan yang disepakati **PARA PIHAK** yang diatur dalam Lampiran III Perjanjian Kerja Sama ini;
22. **Kartu Peserta** adalah kartu kepesertaan yang diterbitkan oleh **PIHAK PERTAMA** sebagai alat bukti yang sah atas kepesertaan seseorang berdasarkan polis asuransi kesehatan yang dikeluarkan oleh **PIHAK PERTAMA** untuk memperoleh Layanan Kesehatan dengan sarana dan fasilitas **PIHAK KEDUA**, Kartu Peserta dengan logo **BRI LIFE** untuk **Layanan Kesehatan Rawat Inap dan Layanan Kesehatan Rawat Jalan** (Contoh Kartu pada lampiran II) yang akan diproses melalui BRILIFE-Care.
23. **E-Card** adalah Kartu Peserta berbentuk digital yang dapat diakses dalam aplikasi BRILIFE-Care.
24. **Formulir Pengajuan Klaim (FPK)** adalah formulir standar **PIHAK PERTAMA**, yang wajib dilengkapi oleh **PIHAK KEDUA** dan disertakan pada saat pengajuan Klaim kepada **PIHAK PERTAMA**;

Hlm. 5 dari 37

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

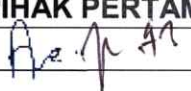
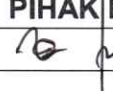
- 25. **Kelas Perawatan** adalah fasilitas Rawat Inap termasuk pelayanan obat yang menjadi hak Peserta sesuai dengan plan pada Kartu BRILIFE yang dimiliki Peserta
- 26. **Coordination of Benefit BPJS Kesehatan** selanjutnya disingkat **COB BPJS Kesehatan** adalah suatu proses dimana dua atau lebih penanggung (payer) yang menanggung orang yang sama untuk benefit kesehatan yang sama, membatasi total benefit dalam jumlah tertentu yang tidak melebihi jumlah pelayanan kesehatan yang dibiayakan, sesuai Peraturan Menteri Kesehatan No. 3 tahun 2023 serta peraturan terkait, peraturan baru atau peraturan tambahan lainnya yang mendukung jalannya pelayanan COB BPJS Kesehatan ini.
- 27. **Provider Irisan** adalah Provider mitra dari **PIHAK PERTAMA** yang terdaftar sebagai sarana pelayanan kesehatan BPJS Kesehatan;
- 28. **Rekam Medis** adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan Provider kepada Peserta;
- 29. **Rawat Inap Tingkat Lanjutan** selanjutnya disingkat **RI** adalah pelayanan yang bersifat spesialisik/ subspesialistik untuk keperluan observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, Rehabilitasi Medis dan atau pelayanan medis lainnya, pada Provider Tingkat Lanjutan yang mana Peserta dirawat inap di ruang perawatan/perawatan khusus paling sedikit 1 (satu) hari;
- 30. **Rehabilitasi Medis** adalah pelayanan yang diberikan oleh instalasi Rehabilitasi Medis dalam bentuk fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, dan bimbingan sosial medik;
- 31. **Rujukan** adalah sistem aturan pelimpahan tugas dan tanggung jawab pelayanan kesehatan secara timbal balik antar Provider Tingkat Pertama dengan Provider Tingkat Lanjutan;
- 32. **Telemedicine** adalah sebagaimana dijelaskan pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 20 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan *Telemedicine* Antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan atau perubahannya dari waktu ke waktu.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

33. **Tindakan Medis** adalah tindakan yang bersifat operatif dan non operatif yang dilaksanakan baik untuk tujuan diagnostik maupun pengobatan sesuai dengan indikasi medis serta tidak berlebihan dan atau terkendali
34. **Verifikasi Klaim** adalah upaya pemeriksaan kelengkapan/kebenaran berkas kelayakan Klaim yang diajukan kepada **PIHAK PERTAMA** oleh **PIHAK KEDUA**/Peserta, sesuai dengan ketentuan
35. **Ekses Klaim** adalah selisih biaya yang timbul antara biaya perawatan di **PIHAK KEDUA** dengan manfaat asuransi yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA**.
36. **Surat Elegibilitas Peserta** yang selanjutnya disingkat **SEP**, surat yang dikeluarkan oleh Fasilitas Kesehatan tingkat 1 dari BPJS Kesehatan untuk di daftarkan ke Fasilitas Kesehatan Lanjutan BPJS Kesehatan.
37. **Surat Pendaftaran/Otorisasi (Letter of Authorization-LoA)** adalah slip pengesahan yang diterbitkan oleh **PIHAK PERTAMA** mengenai batas manfaat asuransi kesehatan atau kebijakan fasilitas kesehatan perusahaan sesuai dengan hak Peserta dan digunakan sebagai informasi bagi **PIHAK KEDUA** dan Peserta melakukan rawat inap dan rawat jalan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 6 Perjanjian Kerja Sama perihal Struk Pengobatan.m
38. **Surat Pengesahan “(Letter of Confirmation-LoC)”** adalah slip pengesahan yang diterbitkan oleh **PIHAK PERTAMA** mengenai batas manfaat asuransi kesehatan atau kebijakan fasilitas kesehatan perusahaan Peserta sebagai informasi bagi **PIHAK KEDUA** dan Peserta yang diterbitkan setelah Peserta melakukan pemeriksaan rawat jalan;
39. **Berkas Softcopy** adalah salinan dokumen/informasi yang berbentuk digital atau elektronik, seperti termasuk namun tidak terbatas pada dokumen word, pdf, dan lain sebagainya.
40. **Berkas Hardcopy** adalah salinan dokumen/informasi yang dicetak langsung berbentuk fisik, seperti termasuk namun tidak terbatas pada memo, nota, katalog, dan sebagainya.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Hlm. 7 dari 37

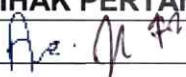
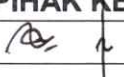
1. Pelayanan kesehatan yang diberikan **PIHAK KEDUA** kepada Peserta meliputi pelayanan Rawat Inap dan Rawat Jalan serta pelayanan kesehatan lain seperti pengobatan dan/atau penggunaan peralatan kedokteran, kamar bedah, pemeriksaan laboratorium/ radiologi dan asuhan keperawatan, serta tindakan lain yang lazim dalam pelayanan kesehatan yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA**.
2. Ruang lingkup dan prosedur pelayanan kesehatan yang dimaksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah
 - a. Prosedur Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan dan Rawat Inap;
 - b. Prosedur Pelayanan Kesehatan COB BPJS KESEHATAN;
 - c. Prosedur Pelayanan Kesehatan Telemedecine.

PASAL 3

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

1. Tanpa mengesampingkan hak **PIHAK PERTAMA** sebagaimana diatur dalam Pasal-Pasal lain dalam Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PIHAK PERTAMA** berhak untuk:
 - a. Melihat dan mengakses kartu status dan/atau Rekam Medis dan berkas fisik atas pelayanan Peserta yang dikirimkan kepada **PIHAK PERTAMA** melalui pertukaran data elektronik, *softcopy* atau *hardcopy* dalam hal diperlukan oleh **PIHAK PERTAMA**;
 - b. Melakukan peninjauan atas pelayanan kesehatan yang diberikan **PIHAK KEDUA** kepada Peserta dengan cara, termasuk tetapi tidak terbatas pada, mendapatkan data dan informasi tentang fasilitas **PIHAK KEDUA** dan kunjungan Peserta;
 - c. Melakukan audit atau pemeriksaan terhadap **PIHAK KEDUA** apabila terdapat dugaan penyalahgunaan pelayanan kesehatan dan/atau surat pesanan obat/resep kepada Peserta atau non Peserta;
 - d. Memberikan teguran atau peringatan lisan dan/atau tertulis kepada **PIHAK KEDUA** dalam hal **PIHAK PERTAMA** menemukan terjadinya penyimpangan terhadap pelaksanaan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini oleh **PIHAK KEDUA**;
 - e. Memberikan sanksi kepada **PIHAK KEDUA** dalam hal **PIHAK PERTAMA** menemukan terjadinya penyimpangan terhadap pelaksanaan kewajiban **PIHAK KEDUA**;
 - f. Menerima data dan informasi termasuk namun tidak terbatas pada dokumen uji tuntas **PIHAK KEDUA**/Provider *due diligence* dalam rangka pemenuhan peraturan

Hlm. 8 dari 37

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

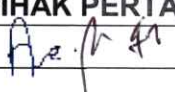
- perundangan, Berkas Elektronik dan/atau dokumen, data lainnya yang dibutuhkan **PIHAK PERTAMA** secara benar, sah dan akurat baik melalui pertukaran data elektronik dan/atau dokumen fisik, apabila diperlukan oleh **PIHAK PERTAMA**;
- g. Menerima tagihan elektronik yang dihasilkan dari Aplikasi **BRILIFE-Care** yang ditetapkan **PIHAK PERTAMA** atas biaya pelayanan kesehatan dan obat bagi Peserta secara teratur setiap bulan kepada **PIHAK PERTAMA**;
 - h. Mendapatkan kepastian bahwa pelayanan kesehatan yang diberikan **PIHAK KEDUA** kepada Peserta sesuai indikasi medis dan standar serta prosedur pelayanan kesehatan yang berlaku atau dengan mengutamakan prinsip kendali mutu dan kendali biaya serta pertanggungjawaban **PIHAK KEDUA** atas pelayanan kesehatan yang diberikan kepada Peserta dalam melaksanakan kewajibannya dalam Perjanjian Kerja Sama ini;
 - i. Menerima dokumen-dokumen termasuk namun tidak terbatas pada tagihan Klaim yang ditandatangani oleh perwakilan sah **PIHAK KEDUA** yang memiliki kapasitas, kewenangan serta cakap untuk melakukan hal tersebut;
 - j. Mendapatkan akses untuk menggunakan seluruh dokumen terkait dengan Klaim untuk kepentingan audit internal/eksternal.
2. Tanpa mengesampingkan kewajiban **PIHAK PERTAMA** sebagaimana diatur dalam Pasal-Pasal lain dari Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk:
- a. Membayar Klaim sepanjang memenuhi ketentuan dan prosedur yang telah disepakati **PARA PIHAK** sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini;
 - b. Memberikan akses Aplikasi **BRILIFE-Care** kepada **PIHAK KEDUA** untuk kepentingan pelayanan kesehatan Peserta

PASAL 4

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1. Tanpa mengesampingkan hak **PIHAK KEDUA** sebagaimana diatur dalam Pasal-Pasal lain dari Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PIHAK KEDUA** berhak untuk:
 - a. Menerima informasi tentang ruang lingkup dan prosedur pelayanan kesehatan yang disediakan bagi Peserta;

Hlm. 9 dari 37

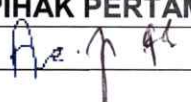
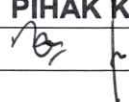
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- b. Memperoleh pembayaran biaya pelayanan kesehatan dari **PIHAK PERTAMA** atas pelayanan kesehatan yang telah diberikan oleh **PIHAK KEDUA**, sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang telah disepakati **PARA PIHAK** sebagaimana diatur dalam pasal 7 Perjanjian Kerja Sama ini;
2. Tanpa mengesampingkan kewajiban **PIHAK KEDUA** sebagaimana diatur dalam Pasal-Pasal lain dari Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
 - a. Memberikan **PIHAK PERTAMA** hak untuk mengakses dan/atau melihat kartu status dan/atau Rekam Medis dan bukti pelayanan Peserta baik secara pertukaran data elektronik, *softcopy* atau *hardcopy* apabila diperlukan;
 - b. Melampirkan seluruh dokumen klaim yang diperlukan oleh **PIHAK PERTAMA** sebagaimana yang diatur dalam pasal 7 ayat (9), ayat (10) dan ayat (11) Perjanjian Kerja Sama ini secara lengkap, benar dan sah
 - c. Memberikan Manfaat Pelayanan dengan baik dan benar sesuai yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini;
 - d. Melayani Peserta dengan baik sesuai indikasi medis dan standar serta prosedur pelayanan kesehatan yang berlaku atau dengan mengutamakan prinsip kendali mutu dan kendali biaya, dan oleh karenanya bertanggungjawab penuh dalam kapasitasnya selaku pemberi pelayanan kesehatan kepada Peserta dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini;
 - e. Dalam hal **PIHAK KEDUA** juga sebagai Provider Irisan maka **PIHAK KEDUA** wajib memberikan pelayanan sesuai mekanisme Manfaat *CoB* BPJS Kesehatan yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, menerbitkan SEP dan juga mengajukan tagihan elektronik dengan mekanisme *split billing* melalui INA-CBG dan selisih yang terjadi dibayar ditempat oleh peserta setelah hasil perhitungan selisih pengurangan INACBG.
 - e. Mengakses dan menggunakan aplikasi **PIHAK PERTAMA** untuk kepentingan pelayanan kesehatan Peserta BRILIFE yang terdiri dari Aplikasi BRILIFE-Care.

PASAL 5

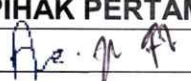
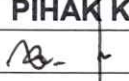
BIAYA PERAWATAN DAN PENGOBATAN YANG TIDAK DIJAMIN OLEH PIHAK PERTAMA

Hlm. 10 dari 37

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

1. Pengeluaran terhadap biaya-biaya yang tidak berhubungan dengan kegiatan yang bersifat Medis yang semata mata untuk kenyamanan Peserta (misalnya: pemakaian fasilitas telepon, *facsimile*, *laundry* dsb).
2. Biaya Operasi dan Perawatan untuk Tujuan Kecantikan, Hemodialisi (cuci darah), Alat Pacu Jantung, Alat Protesa, Alat Bantu Dengar dan Transplantasi Organ Tubuh termasuk Sumsum Tulang Belakang.
3. Penyalahgunaan Kartu Peserta dan adanya penyimpangan fasilitas yang diberikan.
4. Biaya pengobatan terhadap Kondisi Bawaan Sejak Lahir yang telah diketahui dan telah ada sebelum masa Pertanggungan.
5. Biaya Pengobatan Psikosis, Neurosis, Penyakit Jiwa dan Penyakit Mental lainnya (termasuk setiap Manifestasi dari gangguan Kejiwaan atau Psikosomatik).
6. Biaya Perawatan Khusus (Rest Cures) dan Perawatan yang semata-mata hanya untuk membantu seseorang dalam menjalankan kegiatan sehari-harinya (Custodial Care) Contoh: Kursi Roda, Kruk atau Perawatan Suster Pribadi di rumah.
7. Biaya Perawatan penyakit atau cedera yang timbul dari atau berhubungan dengan penyalahgunaan Alkohol, Narkotika atau obat-obatan lainnya (kecuali akibat dari obat-obatan yang berdasarkan resep dokter dan bertujuan medis), Bunuh Diri, Percobaan Bunuh Diri, Cidera yang disengaja, Keterbukaan yang disengaja terhadap Bahaya Besar.
8. Tindakan tindakan atau perlengkapan yang berhubungan dengan aborsi (kecuali atas pertimbangan Medis), PAP's Smear atau Test yang tidak berhubungan dengan pengobatan (Tes Alergi, Penurunan Berat Badan), Sterilisasi dan Mendapatkan Kesuburan, Mendapatkan Bayi Tabung, termasuk penyakit-penyakit yang timbul akibat keadaan tersebut.
9. Pengobatan penyakit atau cedera yang timbul dari atau berhubungan dengan semua jenis olah raga beresiko tinggi.
10. Segala jenis Vitamin, Food Supplement yang dipergunakan bukan untuk suatu penyembuhan, Imunisasi (Imunisasi bukan dasar atau yang bukan program pemerintah seperti DPT Polio Tidak Panas, HIB, MMR), Pemeriksaan Fisik dan Laboratorium yang bertujuan untuk pengecekan kesehatan saja.

Hlm. 11 dari 37

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

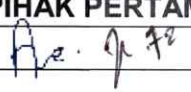
11. AIDS dan ARC (AIDS Related Complex) atau pengobatan yang berhubungan dengan Penyakit Kelamin serta akibat yang ditimbulkan.
12. Terapi Kosmetik, Terapi Disfungsi Seksual.

PASAL 6

PROSEDUR PELAYANAN KESEHATAN

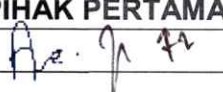
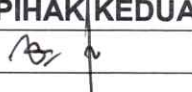
1. **PARA PIHAK** menyetujui prosedur pelayanan kesehatan Rawat Jalan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Peserta berkewajiban untuk menunjukkan Kartu Peserta atau E-card yang masih berlaku beserta Identitas Diri kepada petugas pendaftaran rawat jalan kepada **PIHAK KEDUA**. Kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Kerja Sama ini, apabila Peserta dengan alasan apapun tidak dapat menunjukkan Kartu Peserta maka Peserta tersebut akan diperlakukan sebagai pasien umum yang bukan merupakan tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**.
 - b. Petugas **PIHAK KEDUA** akan memeriksa Kartu Peserta atau E-Card dan hak Peserta berdasarkan manfaat asuransi kesehatan dari Peserta yang bersangkutan dan melakukan validasi melalui Aplikasi BRILIFE-Care.
 - c. Peserta akan menerima pelayanan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku.
 - d. Tagihan atas biaya pelayanan kesehatan tidak ditagihkan kepada Peserta, karena seluruh biaya yang timbul menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**, kecuali jika terdapat ekses, maka ekses tersebut wajib ditagih oleh **PIHAK KEDUA** sebelum Peserta meninggalkan Rumah Sakit **PIHAK KEDUA**.
 - e. Atas permintaan **PIHAK PERTAMA**, **PIHAK KEDUA** wajib memberikan keterangan medis secara tertulis mengenai Peserta. **PIHAK PERTAMA** dengan ini menyatakan bahwa **PIHAK PERTAMA** telah mendapatkan izin dan kuasa dari Peserta untuk meminta dan atau menerima keterangan medis baik secara lisan maupun tertulis dari **PIHAK KEDUA** mengenai kesehatan Peserta dan untuk itu **PIHAK PERTAMA** akan bertanggungjawab penuh atas keterangan medis yang telah disampaikan **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA**.

Hlm. 12 dari 37

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- f. **PIHAK KEDUA** wajib menolak permintaan Peserta untuk mengubah tanggal perawatan, Diagnosa, Pemeriksaan Tes Laboratorium dan Tes Diagnostic.
2. **PARA PIHAK** menyepakati prosedur pelayanan kesehatan Rawat Inap dengan ketentuan sebagai berikut:
- Peserta berkewajiban untuk menunjukkan Kartu Peserta atau E-card yang masih berlaku beserta Identitas Diri kepada petugas pendaftaran rawat inap di **PIHAK KEDUA**. Kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Kerja Sama ini, apabila Peserta dengan alasan apapun tidak dapat menunjukkan Kartu Peserta maka Peserta tersebut akan diperlakukan sebagai pasien umum yang bukan merupakan tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**.
 - Petugas **PIHAK KEDUA** akan memeriksa Kartu Peserta atau E-Card dan/atau Surat Jaminan dan melakukan konfirmasi mengenai validitas Kartu Peserta dan/atau Surat Jaminan dengan hak Peserta berdasarkan manfaat asuransi kesehatan atau kebijakan fasilitas kesehatan perusahaan dari Peserta melalui Aplikasi BRILIFE CARE.
 - PIHAK KEDUA** wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** dengan formulir Pelaporan (konfirmasi) Perawatan Peserta, paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak Peserta menjalani Rawat Inap.
 - PIHAK KEDUA** wajib memberitahukan secara tertulis atau melalui telpon kepada **PIHAK PERTAMA** dengan formulir pelaporan (konfirmasi) perawatan Peserta, paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak Peserta akan melakukan tindakan penunjang medis saat menjalani Rawat Jalan (misalnya: Tindakan BNO-IVP, CT-Scan) untuk mendapat persetujuan dari **PIHAK PERTAMA**.
 - PIHAK KEDUA** wajib memberitahukan secara tertulis atau melalui telepon kepada **PIHAK PERTAMA**, bila penggunaan **obat per item mencapai Rp. 500.000,-** (lima ratus ribu rupiah) dan pemakaian obat-obatan serta **pemeriksaan penunjang** dengan **total biaya lebih dari Rp. 1.000.000,-** (satu juta rupiah) untuk mendapat persetujuan dari **PIHAK PERTAMA**.
 - PIHAK KEDUA** dapat merujuk Peserta untuk dirawat ke Rumah Sakit lain, dalam hal terjadi kerusakan ataupun keterbatasan fasilitas dan kamar perawatan yang dimiliki oleh **PIHAK KEDUA**.
 - Apabila kamar yang menjadi hak Tertanggung penuh, maka Tertanggung dapat ditempatkan di kamar perawatan 1 (satu) tingkat lebih tinggi dari haknya maksimum

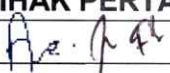
Hlm. 13 dari 37

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam dengan biaya ditanggung oleh **PIHAK PERTAMA**, dimana **PIHAK KEDUA** sebelumnya wajib melakukan pemberitahuan atau konfirmasi terlebih dahulu melalui telepon atau media komunikasi lainnya kepada **PIHAK PERTAMA** dan apabila keesokan harinya kamar yang sesuai dengan hak Peserta sudah tersedia, maka **PIHAK KEDUA** wajib memindahkan Peserta ke kamar yang sesuai haknya. Apabila setelah 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam, kamar yang seharusnya menjadi hak bertanggung masih belum tersedia, maka **PIHAK KEDUA** akan mengkonfirmasi kepada **PIHAK PERTAMA** mengenai hal tersebut apakah bertanggung akan dirujuk ke rumah sakit lain atau selisih biaya perawatan yang timbul menjadi beban bertanggung.

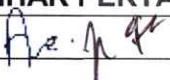
- h. Tagihan atas biaya pelayanan kesehatan tidak ditagihkan kepada Peserta, karena seluruh biaya yang timbul menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**, kecuali jika terdapat eksekusi, maka eksekusi tersebut wajib ditagih oleh **PIHAK KEDUA** sebelum Peserta meninggalkan Rumah Sakit **PIHAK KEDUA**.
 - i. **PIHAK KEDUA** wajib menolak permintaan Peserta untuk mengubah tanggal perawatan, diagnosa, pemeriksaan tes laboratorium dan tes diagnostic.
 - j. **PIHAK KEDUA** wajib menolak pemeriksaan yang secara medis tidak diperlukan dan tidak berhubungan dengan perawatan serta pemberian pelayanan kesehatan atas diri Peserta.
 - k. Apabila pada ayat i dan atau ayat j dalam pasal ini dilanggar maka **PIHAK PERTAMA** berhak memutuskan secara sepihak atas Perjanjian Kerja Sama ini.
 - l. Apabila ada tindakan/pemeriksaan yang memerlukan biaya besar, **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk mengkonfirmasi hal tersebut kepada **PIHAK PERTAMA**.
3. **PARA PIHAK** menyepakati prosedur pelayanan kesehatan COB BPJS KESEHATAN sebagai berikut :
- a. Pemberian pelayanan bagi Peserta sesuai dengan ketentuan/peraturan pelaksanaan sebagaimana telah diatur oleh Peraturan pemerintah/ perundang -undangan.
 - b. Peserta dilayani sesuai dengan alur dari BPJS Kesehatan dan ditawarkan untuk COB BPJS Kesehatan dengan cara **PIHAK PERTAMA** menanyakan kepada peserta **PIHAK KEDUA** apakah ada kartu peserta BRILIFE dan diinformasikan ke peserta bisa melayani COB BPJS Kesehatan.
 - c. Peserta wajib menunjukkan Kartu Peserta, Kartu Peserta BPJS Kesehatan dan surat rujukan dari FKTP (Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama) BPJS Kesehatan yang sah

Hlm. 14 dari 37

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- dan masih berlaku pada petugas pendaftaran rawat inap Rumah Sakit, dan menyerahkan fotokopi kartu peserta BPJS Kesehatan, Kartu Identitas Diri, Surat Rujukan dari FKTP (Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama) masing-masing 2 (dua) rangkap kepada petugas pendaftaran rawat inap Rumah Sakit. (jika diperlukan)
- d. Petugas Rumah Sakit akan memeriksa Kartu Peserta, Kartu Peserta BPJS Kesehatan, kartu identitas diri dan surat rujukan dari FKTP (Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama) dan melakukan konfirmasi mengenai validitas jaminan dan hak fasilitas pelayanan kesehatan yang dapat dipergunakan oleh Peserta. Peserta melengkapi persyaratan administrasi untuk penerbitan SEP maksimal 3 X 24 Jam sejak Peserta masuk Rumah Sakit/sebelum pasien pulang/ pasien meninggal dunia.
 - e. Petugas Rumah Sakit harus cross cek di system BPJS Kesehatan dan juga Sytem Aplikasi BRILIFE-Care, untuk kepesertaan apakah masih aktif atau tidaknya (Eligibility peserta).
 - f. BPJS Kesehatan sebagai penjamin pertama dan Perusahaan/Asuransi Kesehatan Tambahan lainnya merupakan penjamin kedua. Apabila biaya perawatan yang timbul melebihi batas santunan yang ditetapkan dalam polis Asuransi Kesehatan, maka **Selisih Biaya** yang terjadi wajib ditagih oleh **PIHAK KEDUA** sebelum Peserta meninggalkan Rumah Sakit **PIHAK KEDUA**.
 - g. Peserta wajib mengisi dan menandatangani formulir administrasi rawat inap yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA**.
 - h. Peserta yang menginginkan perawatan atau kelas rawat inap yang lebih tinggi dari hak nya harus membayar selisih biaya setiap episode rawat inap. Peserta dapat naik 2 (dua) kelas lebih tinggi dari hak kelas BPJS Kesehatan yang dimiliki. **PIHAK KEDUA** akan merawat Peserta sesuai standar pelayanan **PIHAK KEDUA** dan sesuai hak fasilitas pelayanan kesehatan yang didapat Peserta.
 - i. Peserta dengan hak kelas III tidak diperkenankan untuk naik kelas Rawat Inap. Apabila masih menginginkan naik kelas maka tidak berlaku penjaminan BPJS Kesehatan atau COB BPJS KESEHATAN.
 - j. Pasien tidak ditagih untuk membayar uang deposit bila surat jaminan sudah diserahkan. Semua biaya pelayanan kesehatan yang timbul menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar oleh **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan manfaat.
 - k. Selisih biaya yang terjadi akibat dari kenaikan kelas yang dikehendaki peserta dari hak BPJS Kesehatan yang dimiliki berlaku sesuai Peraturan Menteri Kesehatan No.3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan

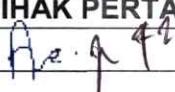
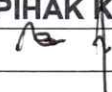
Hlm. 15 dari 37

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Program Jaminan Kesehatan, dimana **PIHAK PERTAMA** membayarkan selisih tarif **PIHAK KEDUA** dengan INA CBG.

- l. Selisih biaya yang terjadi menurut huruf i menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**
 - m. **PIHAK KEDUA** wajib memasukkan jumlah selisih pembayaran yang ditagihan ke **PIHAK PERTAMA** di Aplikasi **BRILIFE-Care**.
 - n. Apabila terjadi selisih setelah verifikasi oleh BPJS Kesehatan maka **PARA PIHAK** akan membicarakan selisih tersebut dengan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku pada kesepakatan **PARA PIHAK**.
4. Dalam hal **PIHAK KEDUA** menyediakan pelayanan *Telemedicine*, maka mekanisme pelayanan *Telemedicine* di **PIHAK KEDUA** sebagai berikut:
- a. Peserta akan menghubungi ruang *chat/call/video call* pada nomor/aplikasi yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA** untuk melakukan pendaftaran.
 - b. **PIHAK KEDUA** meneliti kelengkapan dan keabsahan Peserta dengan meminta Peserta mengirimkan foto kartu Peserta dan kartu identitas (KTP/SIM) untuk dilakukan validasi. Apabila berkas tidak lengkap, langsung diinformasikan ke Peserta untuk melengkapinya.
 - c. **PIHAK KEDUA** melakukan entri dan terbit Surat Jaminan Pelayanan *Telemedicine* secara *realtime* di Aplikasi **BRILIFE-Care**.
 - d. **PIHAK KEDUA** selanjutnya meng-*entry*, mencetak, memberikan pernyataan dan jaminan keaslian atas Surat Jaminan Pelayanan dengan syarat dan mekanisme setiap *entry* harus menggunakan Aplikasi **BRILIFE-Care** dan memilih Surat Jaminan Pelayanan *Telemedicine* serta login dengan username dan password yang sudah diberikan.
 - e. **PIHAK KEDUA** selanjutnya menerbitkan Surat Jaminan Pelayanan (SJP), kemudian ditandatangani oleh Petugas dan tidak mensyaratkan tanda tangan Peserta.
 - f. Peserta yang telah dinyatakan valid di Aplikasi **BRILIFE-Care** mendapatkan pelayanan *Telemedicine* yang ditindaklanjuti oleh **PIHAK KEDUA** dengan memilih dokter yang tersedia dan Peserta akan dihubungi oleh dokter **PIHAK KEDUA**.
 - g. **PIHAK KEDUA** akan merespon pesan Peserta paling lambat dalam 3 menit dan dokter **PIHAK KEDUA** akan menghubungi Peserta paling lambat dalam 3 menit sejak mendapat konfirmasi dari **PIHAK KEDUA**.
 - h. Setelah pelayanan *Telemedicine* selesai, dokter **PIHAK KEDUA** yang memberikan pelayanan kesehatan dan obat menuliskan diagnosa pada bukti kunjungan.

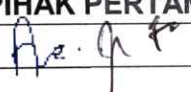
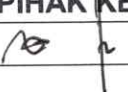
Hlm. 16 dari 37

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

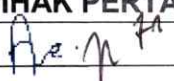
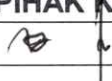
PASAL 7**PEMBAYARAN ATAS JASA PELAYANAN KESEHATAN**

1. Pengajuan tagihan pembayaran dari **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** dapat dilakukan dengan cara *online* .
2. Pengajuan tagihan pembayaran secara *online* sebagaimana dimaksud ayat (1) pada pasal ini dilakukan dengan cara **PIHAK KEDUA** mengunggah berkas *softcopy* melalui BRILIFE-Care.
3. Untuk tagihan Rawat Inap **PIHAK KEDUA** wajib melakukan pengiriman tagihan kepada **PIHAK PERTAMA** dan tagihan tersebut harus sudah diterima paling lambat 14 (Empat Belas) hari kalender untuk pengajuan klaim dengan cara *online* terhitung sejak Peserta keluar dari fasilitas pelayanan Rawat Inap **PIHAK KEDUA** dengan dilengkapi dokumen pendukung penagihan klaim sebagai berikut :
 - a. Foto Copy Kartu Peserta;
 - b. Foto Copy KTP yang bersangkutan
 - c. Formulir Rawat Inap yang ditandatangani Dokter yang merawat dan Peserta.
 - d. Surat Rujukan (jika ada)
 - e. Kuitansi Asli (bermeterai cukup).
 - f. Perincian Biaya Perawatan atas biaya-biaya dan Fasilitas Penunjang yang dipergunakan (Obat, Laboratorium dll).
 - g. Resume Medis.
 - h. **PIHAK KEDUA** dapat melakukan penutupan rekening (pengajuan klaim) bila jumlah biaya pengobatan mencapai $\pm$ Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) meskipun Peserta/ Nasabah/ Karyawan/ Keluarga belum meninggalkan rumah sakit.
4. Untuk tagihan Rawat Jalan **PIHAK KEDUA** wajib melakukan pengiriman tagihan kepada **PIHAK PERTAMA** dan tagihan tersebut harus sudah diterima 14 (empat belas) hari kalender baik pengajuan klaim dengan cara *online* terhitung sejak Peserta mendapatkan fasilitas pelayanan Rawat Jalan dari **PIHAK KEDUA** dengan dilengkapi dokumen pendukung penagihan klaim sebagai berikut:
 - a. Foto Copy Kartu Peserta.

Hlm. 17 dari 37

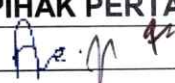
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- b. Formulir Rawat Jalan yang ditandatangani Dokter yang merawat dan Peserta.
 - c. Kuitansi Asli (bermeterai cukup).
 - d. LoA (Letter Of Authoritation) sesuai dengan Aplikasi BRILIFE-Care.
 - e. LoC (Letter Of Confirmation) sesuai dengan Aplikasi BRILIFE-Care.
 - f. Perincian Biaya Perawatan atas Biaya-biaya dan Fasilitas Penunjang yang dipergunakan (Obat, Laboratorium dll).
5. Untuk tagihan *Telemedecine* **PIHAK KEDUA** wajib melakukan pengiriman tagihan kepada **PIHAK PERTAMA** dan tagihan tersebut harus sudah diterima 14 (empat belas) hari kalender baik pengajuan klaim dengan cara *online* terhitung sejak Peserta mendapatkan fasilitas pelayanan *Telemedecine* dari **PIHAK KEDUA** dengan dilengkapi dokumen pendukung penagihan klaim sebagai berikut:
 - a. Foto kartu peserta diupload
 - b. Bukti Transaksi *online*
 - c. Perincian Biaya Pengobatan *online*
 - d. Kuitansi asli bermeterai yang diupload
6. Untuk tagihan COB BPJS **PIHAK KEDUA** wajib melakukan pengiriman tagihan kepada **PIHAK PERTAMA** dan tagihan tersebut harus sudah diterima paling lambat 14 (Empat Belas) hari kalender untuk pengajuan klaim dengan cara *online* terhitung sejak Peserta keluar dari fasilitas pelayanan COB BPJS dengan dilengkapi dokumen pendukung penagihan klaim sebagai berikut:
 - a. Surat penagihan;
 - b. Kuitansi legalisir;
 - c. Fotokopi SEP;
 - d. Fotokopi bukti print out data txt (Coding BPJS Kesehatan);
 - e. Fotokopi dokumen penunjang (pemeriksaan penunjang dll);
 - f. Formulir klaim dari dokter yang merawat dalam bentuk asli (jika ada);
 - g. Fotokopi perincian biaya;
 - h. Fotokopi surat jaminan;
 - i. Fotokopi resume catatan medis;
 - j. Fotokopi hasil laboratorium (jika ada);
 - k. Print out rincian obat (jika ada) surat Penagihan.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

7. Apabila Pasien menggunakan fasilitas kesehatan dari COB BPJS Kesehatan, maka ketentuan pembayarannya sebagai berikut:
 - a. Tagihan Pertama
Tagihan dibayarkan oleh BPJS Kesehatan sesuai ketentuan dalam BPJS Kesehatan
 - b. Tagihan Kedua
Tagihan selisih biaya yang tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan, maka ditagihkan kepada **PIHAK PERTAMA**, dengan tetap melampirkan seluruh rincian tagihan Pasien.
 - c. Tagihan Ketiga
Tagihan selisih biaya yang tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan dan **PIHAK PERTAMA**, maka akan ditagihkan langsung ke Peserta.
8. Bahwa dokumen-dokumen yang dimaksud dalam ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) wajib disampaikan berdasarkan tagihan (*invoice*) per-Peserta.
9. **PIHAK PERTAMA** wajib memberi tanggapan diterima atau ditolaknya dalam batas waktu 14 (empat belas) Hari Kerja sejak dokumen dari **PIHAK KEDUA** diterima **PIHAK PERTAMA** untuk diserahkan kembali ke **PIHAK KEDUA**. **PIHAK PERTAMA** wajib memberikan informasi alasan ditolaknya pengajuan tagihan pembayaran kepada **PIHAK KEDUA**.
10. Dalam hal pengajuan tagihan pembayaran ditolak sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) **PIHAK KEDUA** wajib melengkapi dokumen pengajuan tagihan pembayaran kepada **PIHAK PERTAMA** paling lambat 7 (tujuh) hari kalender.
11. Jika **PIHAK KEDUA** tidak melengkapi pengajuan tagihan pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (10) dalam batas waktu 14 (*Empat Belas*) hari kalender sejak surat informasi penolakan dari **PIHAK PENERIMA** diterima oleh **PIHAK KEDUA**, maka tagihan tersebut dianggap *Kedaluwarsa* dan **PIHAK PERTAMA** *dibebaskan dari kewajiban* pembayaran atas tagihan tersebut.
12. **PIHAK PERTAMA** melakukan pembayaran tagihan biaya **PIHAK KEDUA** tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tagihan **PIHAK KEDUA** diterima **PIHAK PERTAMA** tanpa tanggapan dan atau perubahan tagihan dalam 30 (Tiga Puluh) hari kerja setelah menerima tagihan, dengan mentransfer jumlah yang ditagih ke rekening **PIHAK KEDUA** pada :

Hlm. 19 dari 37

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

RS PRIMA HUSADA MALANG

Bank : PT. Bank Central Asia Tbk
 Kantor Cabang : KK Malang – Singosari
 No. Rekening : 368 - 3040700
 Atas Nama : PT. Disa Prima Medika
 No. NPWP : 21.137.072.1-657.000
 Nama Atas NPWP : PT. Disa Prima Medika

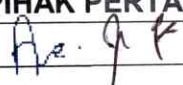
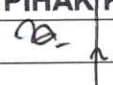
RS PRIMA HISADA SUKOREJO

Bank : PT. Bank Mandiri Persero Tbk
 Kantor Cabang : KK Malang – Sutoyo
 No. Rekening : 144-0055533324
 Atas Nama : PT. Disa Prima Medika
 No. NPWP : 21.137.072.1-657.000
 Nama Atas NPWP : PT. Disa Prima Medika

13. Dalam hal **PIHAK PERTAMA** terlambat dalam melakukan pembayaran tagihan klaim pelayanan kesehatan, maka **PIHAK PERTAMA** akan melakukan pembayaran denda kepada **PIHAK KEDUA** sebesar 5 % (satu persen) dari jumlah yang harus dibayarkan untuk setiap 1 (satu) bulan keterlambatan secara proporsional, setelah **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK PERTAMA** melakukan 2 (dua) kali korespondensi secara tertulis, dengan catatan 2 (dua) kali korespondensi dilakukan dengan jeda waktu diantaranya adalah 5 hari kerja dari korespondensi yang pertama ke korespondensi yang kedua.
14. Apabila **PIHAK KEDUA** lalai dalam mengajukan tagihan kepada **PIHAK PERTAMA** sesuai batas waktu penagihan yaitu 30 (*Tiga Puluh*) hari kalender setelah pasien keluar Rawat Inap dan Rawat Jalan maka tagihan tersebut dianggap *Kedaluwarsa* dan **PIHAK PERTAMA** dibebaskan dari kewajiban pembayaran atas tagihan tersebut.
15. **PIHAK KEDUA** sepakat memberikan *discount* atau potongan harga untuk seluruh pelayanan kesehatan sebesar 1% dari seluruh total tagihan yang akan langsung dikurangi di dalam total tagihan dan masuk dalam system **PIHAK KEDUA**.

PASAL 8
CONTACT PERSON

Hlm. 20 dari 37

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

1. Bahwa setiap Surat menyurat, Pemberitahuan, Permintaan, Persetujuan, Perubahan, Keluhan-keluhan dan lain-lainnya sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini, dilakukan secara tertulis dan dapat disampaikan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya melalui *contact person* yang ditunjuk oleh **PARA PIHAK** untuk menangani/ menindaklanjuti permasalahan/ komplain/ keluhan tersebut ke alamat sebagai berikut:

Contact person sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah:

PIHAK PERTAMA:

Contact Person untuk Perjanjian Kerja Sama, menghubungi:

Nama : Ade Wijayanti
Unit Kerja : *Provider Relation*
No. Hp : 087770070078
Email : ade.wijayanti@brilife.co.id

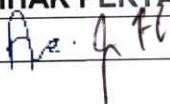
Nama : dr. RR Almira Dhanie, MARS
Unit Kerja : *Provider Relation*
No. Hp : 082260843566
Email : almira.dhanie@brilife.co.id

Nama : Susi
Unit Kerja : *Provider Relation*
No. Hp : 081776672602
Email : susi@brilife.co.id

Alamat PKS : **Gedung Graha Irama**
Jl. HR. Rasuna Said Blok X1 Kav.1-2
Kuningan, Jakarta Selatan, 12950

Contact Person untuk Pelayanan Kesehatan/Jaminan peserta menghubungi **Pelayanan 24 Jam** dinomor:

Call Center/Penjaminan : 150187

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Email : contact.center@brilife.co.id

Contact Person klaim tagihan dan Konfirmasi Pembayaran, menghubungi:

Nama : **Up. Klaim Tagihan Provider**

Email : invoice@brilife.co.id

RS Prima Husada Malang

Contact person untuk Perjanjian Kerja Sama, menghubungi:

Nama : Mayputri Nabilla A.Md.Kes.

Unit Kerja : Humas dan Marketing

No. Telp. : 0811 3507 164

No. Fax. : -

Email : marketingrsphm@gmail.com

Alamat : Jl. Banjararum Selatan No. 3-9 Mondoroko
Kec. Singosari, Kab. Malang

Contact person untuk Pelayanan Kesehatan, menghubungi:

Nama : Daning Pravitia AMd,Keb

Unit Kerja : Pelayanan Medis/ Manager On Duty

No. Telp. : 0811 3110 3113

No. Fax. : -

Contact person untuk Kelengkapan Berkas Tagihan dan Konfirmasi Pembayaran, menghubungi:

Nama : Lilik Kurniati

Unit Kerja : Admin Jaminan Asuransi Rawat Jalan &Rawat Inap

No. Telp. : 081331429720

No. Fax. : -

Email : admklaim.rsph@gmail.com

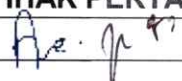
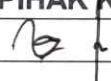
RS Prima Husada Sukorejo

Contact person untuk Perjanjian Kerja Sama, menghubungi :

Nama : Rizqi Gitari Fernanda, A. Md. Kep

Unit Kerja : Humas dan Marketing

Hlm. 22 dari 37

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

No. Telp. : 081315574065
 No. Fax. : -
 Email : backupdatamarketingphs@gmail.com
 Alamat : Jl. Raya Surabaya – Malang KM. 54
 Desa Lemahbang, Kec. Sukorejo, Kab. Pasuruan

Contact person untuk Pelayanan Kesehatan, menghubungi:

Nama : Nur Aini Izzah, S.Kep., Ns
 Unit Kerja : Pelayanan Medis/ Manager On Duty
 No. Telp. : 0811 3031 885
 No. Fax. : -

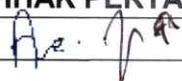
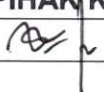
Contact person untuk Kelengkapan Berkas Tagihan dan Konfirmasi Pembayaran, menghubungi:

Nama : Prisna Sandy Faradilla
 Unit Kerja : Admin Jaminan Asuransi Rawat Jalan & Rawat Inap
 No. Telp. : 0821 4203 6398
 No. Fax. : -
 Email : keuanganrsphs@gmail.com

2. Bilamana terjadi perubahan alamat dan/atau nomor rekening **PARA PIHAK**, maka pihak yang alamat dan/ atau nomor rekeningnya berubah wajib memberitahukannya secara tertulis kepada yang lain selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum perubahan tersebut.
3. Segala resiko dan kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat kelalaian dalam memberitahukan perihal perubahan alamat dan/ atau nomor rekening dalam batas waktu tersebut diatas akan menjadi tanggungan pihak yang mengalami perubahan alamat dan/ atau nomor rekening.

PASAL 9
FORCE MAJEURE

Hlm. 23 dari 37

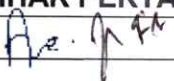
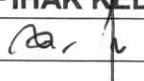
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

1. **PARA PIHAK** Wajib untuk melaksanakan seluruh ketentuan – ketentuan yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerja Sama ini kecuali dalam hal terjadinya *Force Majeure* yang menyebabkan terhentinya atau tertundanya Perjanjian Kerja Sama ini.
2. Keadaan *Force Majeure* adalah segala keadaan atau peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan **PARA PIHAK**, seperti bencana alam, sabotase, pemogokan, huru – hara, *epidemic*, kebakaran, banjir, gempa bumi, perang, Keputusan Pemerintah atau instansi yang berwenang, yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya Perjanjian Kerja Sama ini.
3. Setiap kejadian yang bersifat *Force Majeure* harus diberitahukan kepada Pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya *Force Majeure*. Dengan surat pemberitahuan yang disertai dengan keterangan resmi dari Pejabat Pemerintah setempat yang berwenang.
4. Tidak adanya pemberitahuan hingga lewatnya waktu sebagaimana ditentukan dalam ayat (3) Pasal ini, mengakibatkan Pihak yang lain yang tidak mengalami peristiwa *Force Majeure* berhak untuk tidak mengakui adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut.
5. Biaya biaya yang timbul dan diderita oleh pihak yang mengalami *Force Majeure* bukan merupakan tanggung jawab Pihak lainnya.
6. Pihak yang mengalami *Force Majeure* harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama ini paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah *Force Majeure* tersebut berakhir.
7. Keadaan *Force Majeure* yang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan Perjanjian Kerja Sama akan tetapi hanya merupakan keadaan yang menangguhkan Perjanjian Kerja Sama sampai keadaan *Force Majeure* berakhir.
8. Apabila keadaan *Force Majeure* berlangsung berlarut larut lebih dari 30 (tiga puluh) hari kalender, maka salah satu Pihak dapat menghentikan Perjanjian Kerja Sama secara sepihak dengan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lain.

PASAL 10

KETENTUAN TENTANG KORUPSI DAN PENYUAPAN

Hlm. 24 dari 37

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

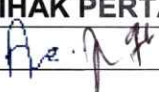
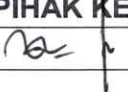
1. **PARA PIHAK** tidak melakukan, memberikan kuasa atau mengizinkan tindakan yang menyebabkan **PARA PIHAK** dan/atau afiliasinya melakukan segala perbuatan yang melanggar hukum yang diatur dalam undang-undang anti korupsi dan/atau peraturan lain yang berlaku. Kewajiban ini berlaku khususnya untuk pembayaran yang tidak sah kepada pejabat pemerintah, wakil-wakil otoritas publik, rekan-rekan **PARA PIHAK**, keluarga atau teman dekat.
2. **PARA PIHAK** setuju bahwa tidak akan menawarkan atau memberi atau setuju untuk memberi kepada karyawan, setiap perwakilan atau pihak ketiga yang bertindak atas nama pihak lain atau menerima atau menyetujui untuk menerima dari setiap karyawan, perwakilan atau pihak ketiga yang bertindak atas nama pihak lain, hadiah atau manfaat baik berupa uang atau lainnya yang mana penerima menurut hukum bukanlah pihak yang berhak sehubungan dengan negosiasi, hasi, atau pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
3. **PARA PIHAK** wajib segera memberitahukan satu sama lain, jika terjadi kecurigaan adanya tindakan korupsi berkaitan dengan hasil negosiasi atau pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
4. **PARA PIHAK** dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini apabila terdapat pembayaran atau pemberian hadiah yang tidak wajar yang dilakukan oleh salah satu pihak sebagaimana disebutkan dalam Perjanjian Kerja Sama ini atau jika salah satu pihak memiliki alasan untuk meyakini bahwa pembayaran atau pemberian hadiah tersebut dilakukan oleh pihak lainnya, hal mana harus dibuktikan terlebih dahulu.

PASAL 11

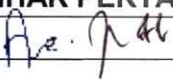
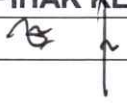
PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME DI SEKTOR JASA KEUANGAN

PARA PIHAK berkewajiban untuk menerapkan hal-hal yang berkaitan dengan nasabah sehubungan dengan Pelaksanaan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan dan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila **PARA PIHAK** maupun pejabat yang berwenang meminta informasi yang berkaitan dengan program APU dan PPT tersebut, maka **PARA PIHAK** berkewajiban memberikan data-data yang berkaitan dengan program APU dan PPT tersebut dengan

Hlm. 25 dari 37

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

ketentuan bahwa permintaan atas informasi nasabah tersebut harus dibuat secara tertulis oleh Pihak yang meminta informasi.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

PASAL 12**JANGKA WAKTU DAN BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJA SAMA**

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (*Lima*) tahun terhitung mulai tanggal **28 Febuari 2025 s/d 27 Febuari 2029**.
2. Salah satu Pihak atau **PARA PIHAK** berhak mengakhiri Perjanjian Kerja Sama. Bagi Pihak yang menginginkan berakhirnya Perjanjian Kerja Sama berkewajiban menyampaikan secara tertulis kepada pihak lain sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian Kerja Sama yang diinginkan.
3. Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini berakhir tidak membebaskan **PARA PIHAK** untuk memenuhi kewajiban yang belum diselesaikan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.
4. Bila pada saat Perjanjian Kerja Sama ini berakhir karena sebab-sebab yang diatur dalam Pasal 7 ayat (6) dan pada saat itu masih ada Peserta yang berada dalam perawatan Jalan di Rumah Sakit **PIHAK KEDUA** maka Peserta tersebut tetap mendapat pelayanan kesehatan dari **PIHAK KEDUA** sampai selesai dan dipulangkan; sesuai batasan etika kedokteran dan etika rumah sakit; dan **PIHAK PERTAMA** mengikatkan dirinya serta bertanggung jawab penuh untuk membayar biaya pelayanan kesehatan Peserta kepada **PIHAK KEDUA** sesuai aturan-aturan yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerja Sama ini

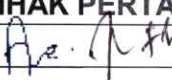
PASAL 13**EVALUASI**

PARA PIHAK menyepakati untuk melakukan evaluasi sekurang-kurangnya satu kali (1 x) sekali setiap tahunnya sejak Perjanjian Kerja Sama ini berlaku yang harus disepakati secara tertulis dalam lembar berita acara.

PASAL 14**ADDENDUM**

1. Perjanjian Kerja Sama hanya dapat diubah, diperbaiki, ditambah, diperbaharui atas persetujuan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam suatu dokumen tertulis yang dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, yang merupakan satu kesatuan

Hlm. 27 dari 37

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

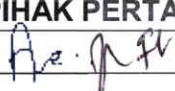
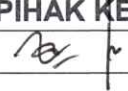
2. Pihak yang menghendaki perubahan **Perjanjian Kerja Sama** ini harus mengajukan permohonan atau memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya guna dilakukan pembicaraan dan pembahasan untuk mencapai mufakat.
3. Hal-hal lain yang belum atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini maupun perubahan yang perlu dilakukan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam suatu dokumen tertulis yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 15

KERAHASIAAN

1. **PARA PIHAK** sepakat dan setuju bahwa segala data dan informasi, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis dan informasi-informasi lain yang berkaitan dengan bisnis, produk dan pelayanan yang diketahui atau timbul berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini adalah bersifat rahasia serta tidak boleh diberitahukan kepada pihak ketiga atau badan/orang lain yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun juga selama dan sesuai Perjanjian Kerja Sama ini.
2. **PARA PIHAK** sepakat untuk tidak membocorkan dan/ atau mempergunakan untuk kepentingan sendiri maupun pihak ketiga segala bentuk informasi, baik berupa data, system kerja, dokumen dan pengetahuan dalam bentuk apapun yang diperoleh berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini tanpa persetujuan tertulis dari Pihak lainnya.
3. **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk menjaga kerahasiaan mengenai Perjanjian Kerja Sama, semua data dan Informasi serta segala bentuk informasi lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
4. Akses atas informasi rahasia harus dibatasi hanya berlaku terbatas bagi pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
5. Ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud Pasal ini berlaku dan mengikat **PARA PIHAK** selama berlangsungnya Perjanjian kerjasama dan tetap berlaku serta mengikat **PARA PIHAK** meskipun Perjanjian Kerja Sama telah berakhir.

Hlm. 28 dari 37

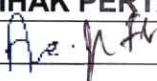
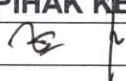
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

PASAL 16
SANKSI

PARA PIHAK mengakui bahwa setiap pelanggaran terhadap Perjanjian Kerja Sama ini dapat menyebabkan kerugian yang tidak dapat diperbaiki dimana ganti rugi dalam bentuk uang tidak mencukupi dan oleh karena itu, atas pelanggaran apa pun terhadap Perjanjian Kerja Sama ini, **PIHAK** yang tidak melanggar berhak untuk meminta ganti rugi yang adil, termasuk perintah dan kinerja khusus, sebagai pemulihan untuk setiap pelanggaran tersebut. Upaya pemulihan tersebut tidak akan dianggap sebagai solusi eksklusif untuk pelanggaran Perjanjian Kerja Sama ini, tetapi akan menjadi tambahan untuk semua upaya hukum lain yang tersedia menurut hukum atau keadilan bagi **PIHAK** yang tidak melanggar.

PASAL 17
PELINDUNGAN DATA PRIBADI

1. Bahwa tidak terlepas dari Pasal 15 tentang Kerahasiaan diperlukan ketentuan khusus mengenai Pelindungan Data Pribadi yang menjadi kewajiban **PARA PIHAK** sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
2. Bahwa **PARA PIHAK** hanya akan melakukan Pemrosesan Data Pribadi Peserta Pertanggungans sesuai dengan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini.
3. **PARA PIHAK** hanya akan mengungkapkan Data Pribadi Peserta Pertanggungans kepada karyawannya atau agen atau subkontraktornya yang tunduk pada kewajiban kerahasiaan yang mengikat sehubungan dengan Data Pribadi.
4. **PARA PIHAK** hanya akan menyediakan Data Pribadi Peserta Pertanggungans kepada personel yang memerlukan akses ke Data Pribadi tersebut untuk memberikan layanan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini.
5. **PARA PIHAK** harus menerapkan langkah-langkah teknis dan organisasi yang sesuai untuk memastikan tingkat keamanan yang sesuai dengan risiko untuk melindungi Data Pribadi dari kehilangan, kehancuran, atau kerusakan dan setiap Pemrosesan yang tidak sah atau melanggar hukum.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

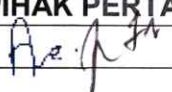
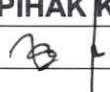
6. Apabila **PARA PIHAK** menerima permintaan dari Peserta Pertanggungan yang menggunakan haknya berdasarkan hukum atau peraturan yang berlaku, maka **PARA PIHAK** harus memenuhi hak tersebut.
7. **PARA PIHAK** harus saling segera memberitahukan satu sama lain mengenai Pelanggaran Data Pribadi atau diterimanya pemberitahuan dari Otoritas Pengawas.
8. **PARA PIHAK** harus melakukan upaya yang wajar untuk mengidentifikasi penyebab Pelanggaran Data Pribadi tersebut dan mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu untuk menentukan penyebabnya dan untuk mencegah Pelanggaran Data Pribadi tersebut terulang kembali.
9. Selama jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** satu sama lain harus menyediakan semua informasi yang relevan yang secara wajar diperlukan untuk menunjukkan kepatuhan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini dan hukum atau peraturan yang berlaku, dan harus mengizinkan dan bekerja sama secara wajar dengan audit, termasuk inspeksi.

PASAL 18

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Perjanjian Kerja Sama ini diatur dan tunduk pada hukum serta hanya dapat ditafsirkan menurut dan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
2. Perselisihan yang timbul dari Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mencapai mufakat dalam waktu maksimal 30 hari (kalender).
3. Apabila dalam waktu sebagaimana ayat (2) diatas **PARA PIHAK** tidak berhasil menyelesaikan perselisihan yang timbul secara musyawarah untuk mencapai mufakat, maka **PARA PIHAK** setuju untuk menempuh penyelesaian melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
4. Untuk Perjanjian Kerja Sama ini dan segala akibatnya, **PARA PIHAK** sepakat untuk memilih tempat kedudukan hukum (domisili) yang tetap pada Kantor Kepaniteraan **Pengadilan Negeri Jakarta Selatan**.

Hlm. 30 dari 37

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

PASAL 19
LAIN-LAIN

1. **PARA PIHAK** sepakat bekerja sama dengan didasarkan pada itikad baik dan akan memenuhi semua kewajiban berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini.
2. Perjanjian Kerja Sama ini disertai dengan lampiran-lampiran yang merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini serta mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sebagaimana halnya Perjanjian Kerja Sama.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini telah disepakati dan ditandatangani, dibuat dalam 2 (dua) rangkap, bermaterai cukup dan masing-masing dipegang oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA
PT ASURANSI BRI LIFE

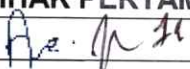
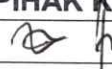


Anna Novy Handayani
Kepala *Project Healthcare*

PIHAK KEDUA
PT DISA PRIMA MEDIKA



dr. Sefrina Trisadi, Sp. DVE
Direktur

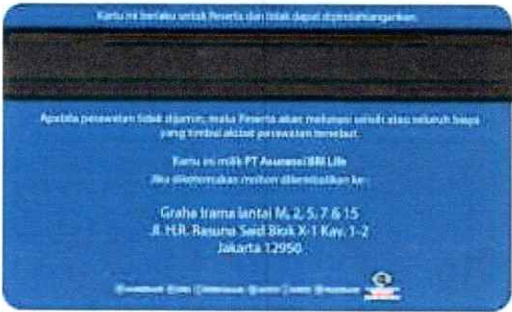
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

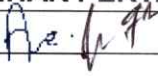
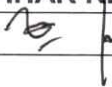
LAMPIRAN I

KARTU PESERTA ASURANSI KESEHATAN
PT. ASURANSI BRI LIFE



PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA



PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

LAMPIRAN II

LOA



RS MCSYS MEDIKA
JALAN JAPAT
NONE
MID .

Nama Peserta : Datuk sipatoka
No Kartu : 7137209000311541
Tanggal Lahir : 18-09-1992
No Polis : 31317
Masa Polis : (01-01-2020 s/d 31-12-2028)
Klien : PT. MCSYS INDEMNITY

****PENDAFTARAN PASIEN OUTPATIENT****
****INFORMASI BENEFIT****

1.	DOKTER & OBAT	20,000
2.	KB	500,000
3.	IMUNISASI DEWASA (DIATAS 12 TAHUN)	500,000
4.	KONSULTASI DOKTER UMUM	150,000
5.	KONSULTASI DOKTER SPESIALIS	SESUAI TGHN
6.	PERAWATAN GUSI	200,000

****CATATAN** :**

karyawan baru belum mengerti aplikasi jadi minta kami bantu

- EXCESS DIBAYAR DITEMPAT.
- ADMIN DIJAMIN DLM JASA DOKTER.
- VIT/SUPP SESUAI DIAGN, BUKAN OBAT UTAMA.
- BCG,DPT,POLIO.CAMPAK.HIB, MMR (<5 THN).
- FLU,HEP A,HEP B,THYPM,VARICELA (<5 THN).
- INFEKSI GENETALIA&INFERTIL TDK DIJAMIN.
- KNTRL HAMIL ANAK >3 & USG4D TDK DIJAMIN.
- GOL PELEMBAB & NON MEDIS TIDAK DIJAMIN.
- HAK KAMAR 1000

2023/11/15

.....TTD.....
Re-Print



PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

LOC



RS MCSYS MEDIKA
JALAN JAPAT
NONE
MID :

Nama Peserta : Datuk sipatoka
No Kartu : 7137209000311541
Tanggal Lahir : 18-09-1992
No Polis : 202009911M0011
Masa Polis : (01-01-2020 s/d 31-12-2028)

****BIAYA PELAYANAN RAWAT JALAN****
ICD10 : Z22.0
IZIN SAKIT : 0

****DIBAYAR ASURANSI****

1. DOKTER &	Rp.	undefined
2. OBAT	Rp.	20.000.00
3. KONSULTASI DOKTER UMUM	Rp.	150.000.00
TOTAL	Rp.	170.000.00

****DIBAYAR PESERTA****

1. DOKTER &	Rp.	undefined
2. OBAT	Rp.	280.000.00
3. KONSULTASI DOKTER UMUM	Rp.	250.000.00
TOTAL	Rp.	530.000.00

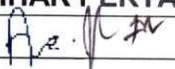
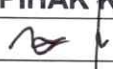
****CATATAN** :**
karyawan baru belum mengerti aplikasi jadi minta kami bantu

2023/11/15

.....TTD.....
Re-Print



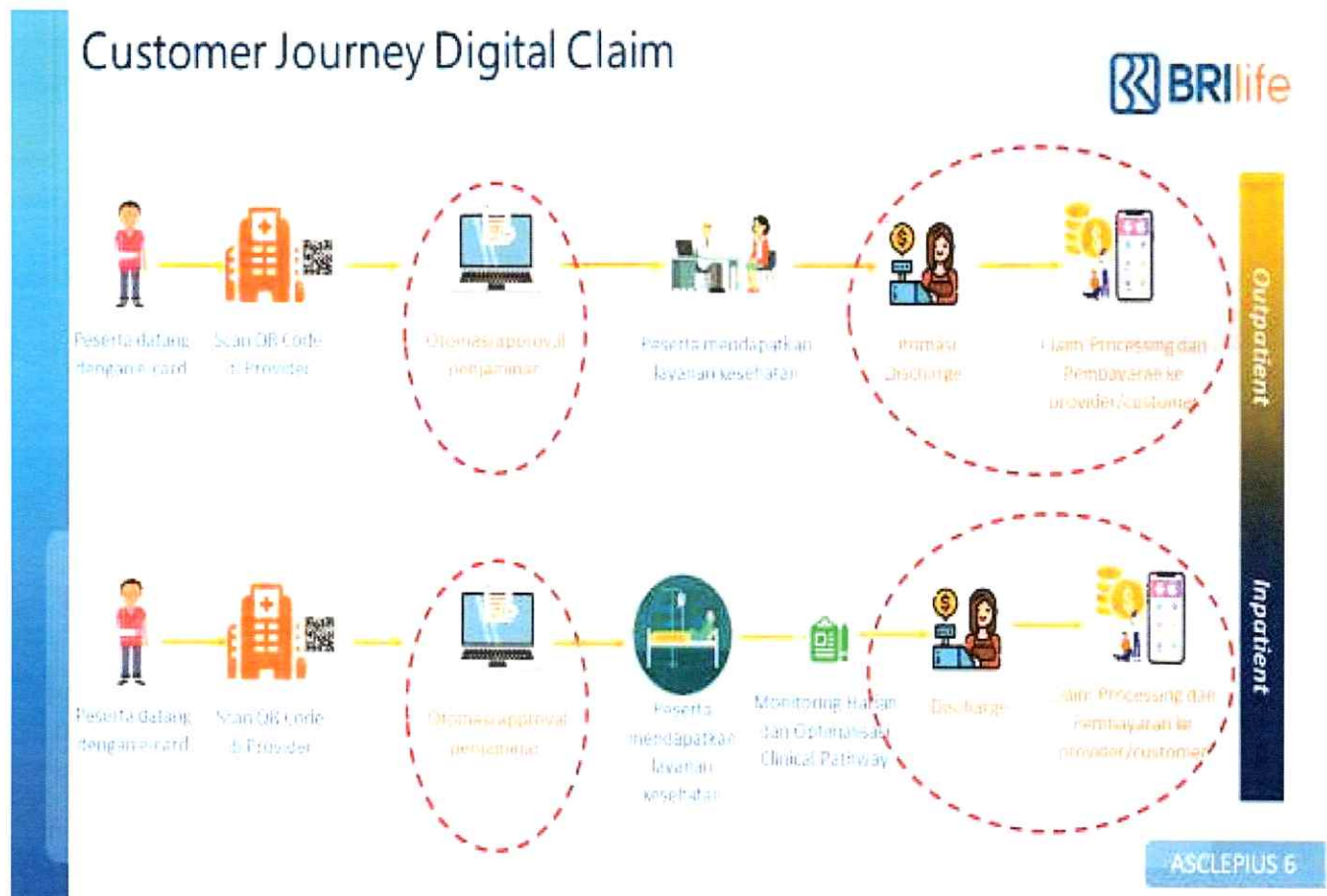
2311080000001

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Hlm. 35 dari 37

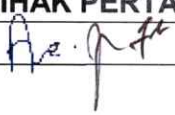
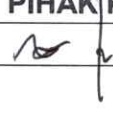
LAMPIRAN III

PROSEDUR LAYANAN PESERTA BRILIFE



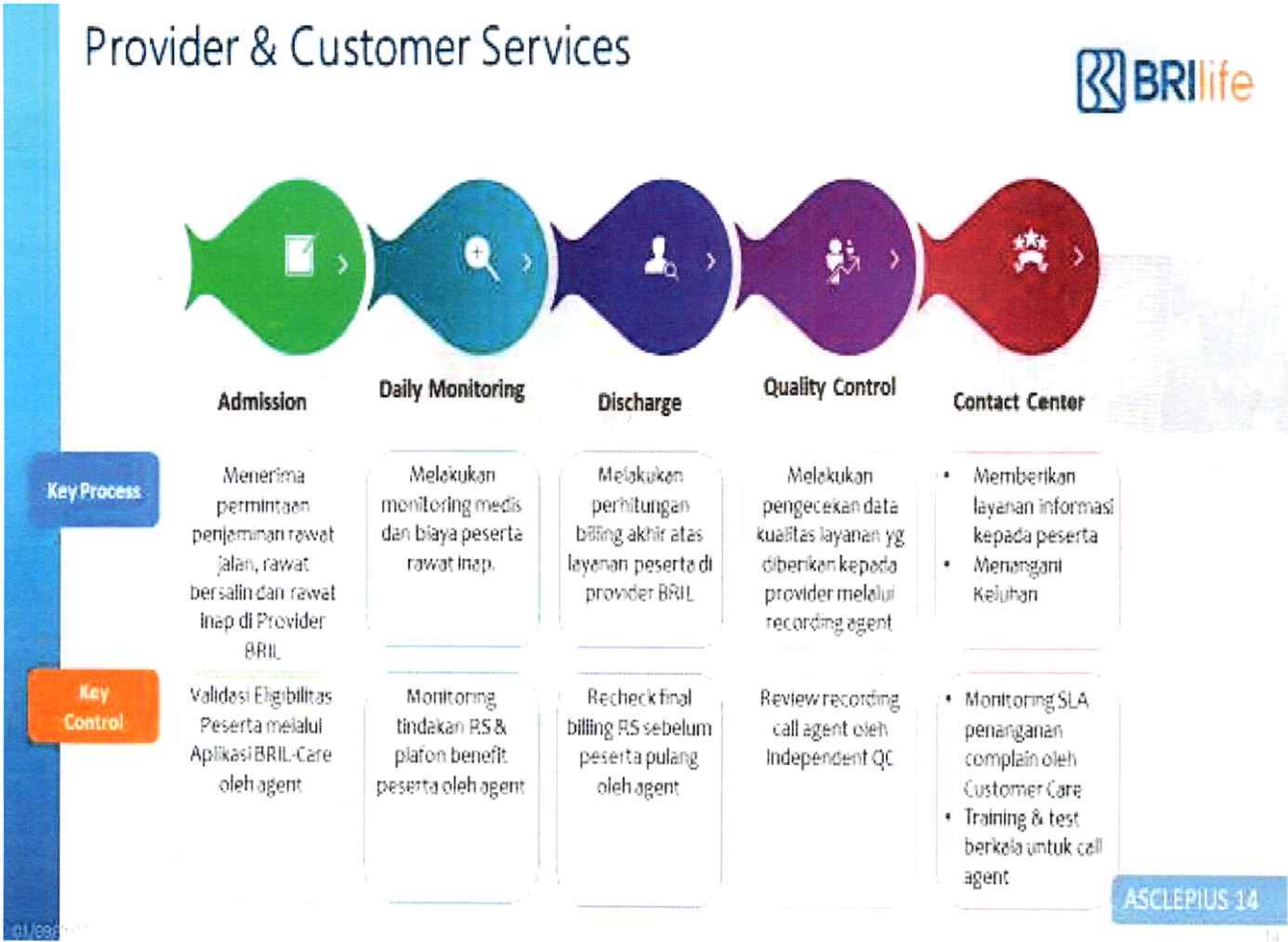
Catatan :

Penjaminan dapat dilakukan dengan cara : Scan Barcode atau menunjukkan kartu fisik yang akan dimasukkan dalam Aplikasi BRILIFE-Care

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

LAMPIRAN IV

ALUR PELAYANAN INTERNAL PIHAK PERTAMA



PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA